



PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

PSICOPATOLOGÍA DE LA CONCIENCIA

La conciencia puede considerarse como un proceso psicológico de orden superior incluyéndose, entre sus funciones, las de control ejecutivo del pensamiento y la acción. Por ello, las alteraciones de la conciencia van a conllevar, en menor o mayor medida dependiendo de su gravedad, una alteración del resto de procesos psicológicos como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el área motora, el área afectiva, etc.

ALTERACIONES CUANTITATIVAS DE LA CONCIENCIA: Se centran en la descripción de los **estados alterados** de conciencia en **función del grado de elevación o disminución** del nivel de conciencia normal o estado de vigilia.

POR ELEVACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA:

Hipervigilancia (como elemento de la conciencia)	El individuo se encuentra en un awareness con mayor sensibilidad sensorial, con un aumento motor e intensidad emocional. El sujeto está en búsqueda constante de posibles amenazas, que lo vuelve más irritable, agotado física y mentalmente. Este estado puede ser producido por intoxicaciones, situaciones de alto estrés, etc.). Awareness: Estado funcional donde el individuo puede realizar un procesamiento significativo de recepción de estímulos internos o externos y puede emitir una respuesta. Hay una buena habilidad perceptiva y cognoscitiva con un aprendizaje y atención óptimas (claridad de conciencia).
Hiperfrenia	Estado de hipervigilancia máxima; conciencia exagerada.

POR DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA:

Obnubilación	- Describe el primer estadio de disminución del nivel de conciencia, caracterizándose por una dificultad para mantener el estado de alerta necesario para responder adecuadamente a los estímulos del contexto, de tal manera que se requieren estímulos externos de cierta intensidad para poder percibirlos. - Esta alteración se acompaña de un cierto nivel de deterioro de otros procesos psicológicos como la atención, la percepción, el pensamiento y la memoria, además de la conciencia limitada al entorno, si bien no se pierde por completo la capacidad de reconocimiento. De este modo, el paciente puede entender y ejecutar lentamente órdenes sencillas (p. ej., sacar la lengua o dar la mano). - Esta alteración puede estar presente en muchas enfermedades degenerativas y traumáticas, así como en una amplia variedad de condiciones orgánicas, como intoxicación por drogas y alcohol, meningitis, etc. También puede ocurrir en diversos trastornos mentales, como la esquizofrenia, la depresión, etc
---------------------	--

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Somnolencia, letargia o sopor	• Es un estado constante y es el siguiente nivel de deterioro progresivo de la conciencia. El paciente está «despierto», pero se quedará «dormido» si se queda sin estimulación sensorial. Se describe a sí mismo como lento para actuar, con dificultades para hablar, perezoso en sus planes y adormecido. • Hay un intento de evitar los estímulos dolorosos. Los reflejos, incluyendo la tos y la deglución están presentes pero reducidos; el tono muscular también disminuye. • Se caracteriza por una disminución de la actividad psicomotora y de la capacidad para reaccionar a los estímulos externos, que deben ser más intensos para provocar una reacción en el paciente • Es importante, señalar que debe diferenciarse entre la somnolencia normal que se produce antes de iniciar el sueño y aquella originada por factores patológicos (infecciones, trastornos metabólicos, estados tóxicos, epilepsia, trastornos cerebrovasculares, daño cerebral, etc.)
Estupor	• Se caracteriza por falta de reacción y atención al ambiente; el paciente se muestra generalmente inmóvil y sólo le es posible alcanzar un ligero estado de alerta mediante estímulos muy potentes. Por tanto, no son capaces de emitir ninguna conducta intencional y las ocasionales respuestas verbales son incoherentes o ininteligibles • En este estado, es imposible explorar el contenido del pensamiento. Puede haber actividad motora estereotipada, movimientos temblorosos y reflejos positivos de presión y succión • Tradicionalmente, se ha distinguido entre el estupor de origen neurológico y el estupor de origen psiquiátrico, refiriéndose este último, en su acepción más amplia, a todos aquellos estados caracterizados por mutismo, reducción de la actividad motora y fluctuación de la conciencia. Los diferentes tipos y características del estupor psiquiátrico serán revisados en el apartado dedicado a las alteraciones cualitativas de la conciencia.
Confusión mental o estado confusional	• Hay afectación en los procesos cognitivos del sujeto, concepción desordenada de la realidad, pérdida leve de la memoria e incoherencia en relación con uno mismo y el mundo exterior. • Se caracteriza por facies de extrañeza que tiene el paciente que lo posea. • Éste se encuentra totalmente desorientado y no comprende lo que sucede a su alrededor. • El paciente es incapaz de mantener una diálogo comprensible, a pesar de sus esfuerzos para hacerse entender.



PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Coma	- Describe una forma prolongada de suspensión global de la conciencia en la que resulta imposible despertar al paciente a pesar de una estimulación intensa. - Alteración que se caracteriza por la pérdida de conciencia, de sensibilidad y de motilidad voluntaria, desapareciendo incluso el funcionamiento reflejo, y en el que se conservan solo las funciones vegetativas - Los tipos de coma más frecuentemente descritos son: los tóxicos (producidos por intoxicaciones etílicas, barbitúricos y otras drogas); los metabólicos (hipoglucémico, hepático, urémico, etc.); y los cerebrales (resultado de accidentes cerebrovasculares, traumatismos, tumores, etc.)
ALTERACIONES CUALITATIVAS DE LA CONCIENCIA: Aunque también se van a caracterizar por un descenso en los niveles de conciencia o vigilia, este se acompaña de una alteración global de las funciones cognitivas (pudiendo estar presentes, delirios, alucinaciones, etc.), y/o de una restricción del campo de la conciencia.	
Delirium	- Es una alteración orgánica que implica un deterioro cognitivo global que no se explica por la existencia de una demencia y que suele tener un curso agudo y una duración relativamente escasa (hasta dos semanas) - Presencia de alteraciones sensorio-perceptuales del tipo de las ilusiones y alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, lo que motiva una alteración de la afectividad y de la conducta en relación con estas manifestaciones perceptuales. - Común verlo en el Delirium Tremens del alcoholismo, donde el paciente se sacude constantemente para quitarse supuestos bichos que le caminan por encima.
Estado Crepuscular	- Son estados transitorios de inicio y fin súbitos de duración variable (desde pocas horas hasta días), con amnesia lacunar posterior, caracterizados por estrechamiento de la conciencia (similar a la de los estados hipnóticos), ausencia de atención al entorno, curso del pensamiento confuso y explosiones emocionales junto con conductas automáticas y alteraciones de la identidad. El paciente puede realizar actos violentos e inesperados, aunque también puede que la conducta sea tranquila. - Este término se restringe a alteraciones producidas por la epilepsia (fundamentalmente del lóbulo temporal), y se diferencia de los estados disociativos de fuga, en los que no hay etiología orgánica demostrable.
Estados oniroides	- Son estados alterados de conciencia donde el sujeto experimenta con una elevada claridad y vive las ilusiones o alucinaciones - generalmente de naturaleza escénica y multimodal, que, dependiendo de su contenido, pueden provocar reacciones emocionales de intenso terror o, por el contrario, de alegría o diversión, así como respuestas motoras consistentes con el contenido emocional (p. ej., agitación o estados de acinesia). - Tiene relación con el sueño, a las vivencias oníricas, que suceden durante el sueño. No es tan profundo como en otros estados. Se mezcla la realidad y la fantasía. Alucinaciones escénicas, es contemplativo, como si estuviera viviendo una película, son por lo general visual y a auditivas, a veces se acompañan de cierta actividad motora. Normalmente comienzan con una alteración del sueño que se altera por la presencia de pesadillas

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Automatismos	- Los automatismos implican una acción que tiene lugar en ausencia de conciencia. - Un automatismo es una parte involuntaria del comportamiento sobre el cual un individuo no tiene control. - El comportamiento en sí es generalmente inadecuado a las circunstancias, y puede no corresponderse con carácter de la persona. - Puede ser complejo y coordinado, y parecer intencional y dirigido, aunque con falta de juicio. Posteriormente, el individuo puede no tener ningún recuerdo o alguno parcial y confuso de sus acciones.
---------------------	---

PSICOPATOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN

La orientación permite situarnos a nosotros mismos en relación con determinadas referencias del contexto y personales (tiempo, lugar, y persona).

Desorientación alopsíquica en tiempo	Cuando al preguntarle, no es capaz de reconocer la hora, el día, el mes o el año en que estamos. A veces no sabe diferenciar si es de día o de noche
Desorientación alopsíquica en espacio	Cuando no puede reconocer el lugar en que está situado, la ciudad o localidad donde vive o donde se encuentra, la provincia o el país, etc. no puede reconocer el espacio que le rodea.
Desorientación autopsíquica o en persona	Cuando no puede identificar quien es, de donde viene o a donde se dirige, desconoce a las demás personas que le rodean habitualmente, tales como amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo o estudios, etc., y que él conoce de antemano. También estará desorientado en persona cuando no pueda identificarse a sí mismo. Está imposibilitado de saber quién es él mismo.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

PSICOPATOLOGÍA DE LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

La atención es la focalización activa o pasiva de la conciencia en una experiencia de estímulos sensoriales, conductas motoras, recuerdos o representaciones internas. Se puede definir como el proceso que realiza una información e inhibe las demás, lo que nos permite seleccionar la información para su posterior procesamiento (Smith y Kosslyn, 2007).

Aprosexia	• Denominada también a veces inatención, ya que implicaría una reducción máxima de la disposición atencional, es decir, una ausencia total de atención. • A veces, el término aprosexia se restringe a la falta de atención total, como ocurriría, por ejemplo, en el coma, mientras que la inatención se utiliza para un tipo específico de alteración que se produce por exceso de fijación de la atención, ya que la persona parece prestar atención únicamente a sus contenidos mentales, se muestra ensimismada, y manifiesta una incapacidad de cambiar el foco de la atención.
Hipoprosexia	• Existe una disminución de la capacidad atencional. • La persona presenta una capacidad disminuida para enfocar, concentrarse y orientarse hacia un objeto. Se trata de un trastorno de la capacidad de prestar atención persistentemente a una determinada actividad, objeto o vivencia.
Hiperprosexia o Hiperconcentración	• A veces también se denomina hiperconcentración o estrechamiento de la atención. • Hacen referencia a alteraciones que se caracterizan por una focalización excesiva y transitoria de la atención sobre un estímulo, aspecto, tema, o vivencia. • Se trataría de una concentración excesiva, tenaz y constante sobre un estímulo o grupo de estímulos, con exclusión de otros que suceden alrededor de la persona. • Como la mayoría de las alteraciones atencionales, este tipo de anomalías se producen en personas sin psicopatología, aunque también puede estar presente en pacientes que presentan trastornos depresivos, trastornos obsesivos o trastornos psicóticos, entre otros.
Pseudoaprosexias	• Suele referirse a la falta de atención hacia el entorno, a pesar de mantener conservada la capacidad atencional. • Impresiona una aprosexia pero la atención se encuentra focalizada en el medio externo del individuo.
Paraprosexias	• Esta alteración indicaría solo una dirección anómala de la atención. • Ocurren desviaciones de la atención de apariencia involuntaria. A causa del detrimento de la atención voluntaria, la atención espontánea se exacerba. Además, se observa un incremento psicomotriz.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Distraibilidad o Distractibilidad	- Podría definirse como inestabilidad atencional y se manifiesta cuando la persona tiene dificultades para prestar atención a un estímulo, aspecto, tema, o vivencia. - Tiene disminuida su atención activa sin que necesariamente su atención pasiva esté aumentada. Su pensamiento “está flotando”, “vaga” hacia recuerdos sin importancia y no puede concentrarse en lo que está haciendo. - El interlocutor aprecia que el enfermo distraído es incapaz de mantener el dialogo o de realizar las tareas más elementales
Hipervigilancia	Escudriñamiento continuo en búsqueda de determinadas señales o indicios, externas [p. ej., en el ambiente] o internas [p. ej., en el propio cuerpo]. - Su atención pasiva exageradamente aumentada y se ve imposibilitado para fijar su atención activa en ninguno de los hechos que ocurren a su alrededor. - Está pendiente de todo lo que sucede cerca de él. Está en un estado de alerta constante y es capaz de captar hechos que para las personas sanas son insignificantes y no puede concentrarse en ninguno de ellos específicamente, o si lo hace, sólo es por un breve instante.
Fatigabilidad de la atención	Se referiría a la modificación causada por el efecto de mantener la atención, que se acompaña de escasos rendimientos y abundancia de errores. Consistiría en un agotamiento de la atención. Puede ser consecuencia de factores cerebrales, es decir, por causas como traumatismos, tumores, procesos demenciales, etc.
Apatía de la atención	- También se denomina indiferencia atencional, o incluso inatención apática, y hace referencia a una considerable falta de atención para interesarse por los acontecimientos, siendo ineficaces los estímulos que despiertan interés en situaciones normales. - La persona no presta atención a acontecimientos del medio ambiente que normalmente interesarían a cualquier otro. Se puede encontrar en síndromes orgánico-cerebrales, en algún subtipo de esquizofrenia, etc.
Perplejidad de la atención	- Alteración cualitativa de la atención. - El sujeto es incapaz de sintetizar el contenido de lo atendido, no logra comprender sus acciones y las circunstancias que lo rodean.
Sesgos atencionales	Tendencia a dirigir la atención, selectiva y prioritariamente, hacia el procesamiento de la información material que es relevante para la persona, porque, por ejemplo, es congruente con sus miedos, preocupaciones, o su el estado de ánimo.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

PSICOPATOLOGÍA DE LA MEMORIA

La memoria es una de las facultades superiores del ser humano, y se refiere a la capacidad para almacenar, retener y recuperar información.

Hipomnesia	• Disminución de la memoria. – Hipomnesia de fijación o anterógrada. Cuando la deficiencia se refiere a hechos ocurridos recientemente. – Hipomnesia es de evocación o retrógrada. Incapacidad para recordar el pasado, o, dicho de otro modo, como la incapacidad para recuperar información que había sido almacenada con anterioridad al inicio del cuadro.
Amnesias	• La amnesia es la pérdida total o casi total de la memoria relacionada con un período de la vida del paciente. • No debemos confundir la verdadera amnesia de la que puede presentarse en pacientes que han tenido un estado de toma de conciencia, pues en ellos no ha podido fijarse la imagen del recuerdo o imagen <i>mnésica</i>, dada la profunda afección de su sistema nervioso que se lo ha imposibilitado. – Amnesia de fijación: Es la incapacidad para consolidar nuevos recuerdos. Cuando una persona padece este tipo de amnesia, se dice que “vive en el presente”, que no recordará nada de su pasado. Dentro de esto están las “amnesias anterógradas”. Las amnesias anterógradas siempre son de causa orgánica y se producen a consecuencia de un acontecimiento de índole neurológico. – Amnesia de conservación: Es la incapacidad de recordar algo, una pérdida de recuerdos de los que ya están almacenados. No todos los recuerdos tienen la misma facilidad de ser olvidados. La “Ley de Ribot” dice que aquellos recuerdos más recientes, menos organizados y automatizados, son más vulnerables a que se pierdan. Hay diferentes tipos de amnesia de conservación. ➤ Global: Una persona puede llegar a perder todos los recuerdos de su pasado. ➤ Lacunar: Los recuerdos que se pierden están delimitados en el tiempo. ➤ Selectivas: Se dividen en dos tipos: ▪ Episódicas: Se olvida un acontecimiento específico de la vida. ▪ Semánticas: Lo que se pierden son los conocimientos, o ciertos tipos de conocimientos. – Amnesia de evocación: Cuando el recuerdo no se pierde, pero es muy difícil traerlo a la memoria, cuando la persona no recuerda algo, pero tiene la sensación de saberlo. Tal vez esto pueda deberse a un estado emocional alterado (mucha ansiedad), astenia, falta de atención, exposición a contenido que interfiere en la capacidad para recuperar información, etc. – Pseudoamnesia: Las personas con esta alteración de la memoria tienen la sensación de que han perdido la memoria, pero objetivamente no hay tal pérdida. Las agnosias, por ejemplo, son amnesias sensoriales, no se reconoce algo que se ve, se toca, se huele, etc. Este tipo de amnesia es de causa orgánica.
Hipermnesia	• Aumento exagerado de los recuerdos. • Estos pacientes son capaces de reproducir todos los detalles de sucesos pasados que incluso aparentemente no habían despertado su atención.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Pseudohipermnesias	• Evocación repetitiva de recuerdos, por ejemplo, relacionados con la patología del paciente y que los puede usar para afianzar su argumentación. • Puede darse en población normal (p. ej., flashes de vivencias pasadas)
Ecmnesia	• Se produce cuando el sujeto cree estar en el pasado, lo que supone revivir con gran implicación emocional vivencias del pasado. • Se produce una pérdida de la orientación en el presente. • El delirio ecmésico hace referencia a la sensación de revivir algún recuerdo auténtico como si fuera presente en un proceso delirante o alucinatorio.
Paramnesias	• Deformidad de los recuerdos. • Creen recordar hechos reales pero deformados, o sencillamente están seguros de recordar hechos que en la realidad no les han ocurrido antes. • Es importante diferenciar la paramnesia de la mentira, también llamada pseudología fantástica.
Confabulaciones	• Mezcla de recuerdos falsos y verdaderos. La persona relata cosas que no han sucedido intentando compensar la pérdida de la memoria respecto a lo que se quiere recordar.
Parapraxias	• Errores de memoria simples, como el olvido de nombres, fechas, el fenómeno de "en la punta de la lengua" • Por tanto, estos términos hacen referencia tanto a distorsiones en el recuerdo como en el reconocimiento. • Es importante señalar que se producen tanto en población normal como clínica, por lo que no necesariamente están asociados a alteraciones mnésicas
Dejá vu o falso reconocimiento positivo	• Se experimenta que algo ya se había visto antes cuando realmente sabemos que es la primera vez que lo vemos. Dos fenómenos asociados: • Pseudopresentimiento: Sensación de haber visto un suceso que hubiera sido capaz de predecir. • Paramnesia reduplicativa: Falso reconocimiento (afirmar, por ejemplo, que se estuvo en el mismo lugar anteriormente siendo la primera vez que está). Frecuente en el síndrome de Korsakoff, los estados confusionales y las demencias
Jamais vu o falso reconocimiento negativo	• El individuo reconoce y recuerda una situación, pero no experimenta sensación de familiaridad alguna. • Fenómeno relacionado: pérdida del significado de las palabras, en el que se produce una articulación correcta de la palabra, pero sin significado cuando se presta atención a la misma.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

PSICOPATOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN, IMAGINACIÓN Y SENSACIONES

La percepción es un proceso cognitivo mediante el cual aprendemos la realidad. Las alteraciones en este proceso suelen atraer gran interés, ya que a veces indican un deterioro grave en el grado de contacto que el paciente mantiene con la realidad, como en el caso de las alucinaciones.

DISTORSIONES SENSORIALES: ANOMALÍAS EN LA PERCEPCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LOS ESTIMULOS

Hiperestesias:	• Aumento exagerado de las sensaciones frente a los estímulos sin que exista modificación del tipo de sensación que debe producir dicho estímulo. O sea que el paciente aqueja sentir desproporcionadamente intenso un estímulo que para otra persona normal no lo es.
Hipoestesias:	• La hipoestesia es la sensación opuesta al caso anterior. • Existe es una disminución de la sensación habitual o normal, que debe producirse frente a un estímulo determinado. Entre ellas podemos señalar la hipoacusia que es la disminución de la audición
Retardo o enlentecimiento de la percepción:	• Como su nombre indica es la lentitud que presenta el enfermo para percibir los fenómenos que se suceden a su alrededor, en relación con la unidad de tiempo. Este fenómeno es característico de las depresiones, sobre todo las de nivel psicótico.
Anestesias:	• Es la abolición o falta total de las sensaciones par uno o varios estímulos sensoriales. • Las anestias al sonido son las llamadas acusias o sorderas, las que tienen que ver con la visión son las cegueras, ambliopías o amaurosis, las que están relacionadas con el tacto son las táctiles y en estos casos el paciente pierde las sensaciones térmicas, dolorosas, etc. en su piel.
Hiperalgesias	• Percepción exagerada de la intensidad del dolor: “cualquier golpecito, por pequeño que sea... es como si me dieran con un martillo, me retumba y me duele por todo el cuerpo”
Hipoalgesias	• Percepción muy escasa de estímulos que causan dolor: “nada me afecta, nada me impresiona, me golpeo con la cabeza en la pared para ver si noto algo, pero apenas nada... como si fuera un colchón la pared”
Analgesia	• Ausencia total de percepción de dolor: de ahí que ciertos fármacos destinados a disminuir el dolor físico se denominen, genéricamente, “analgésicos” (otras veces aun es peor... me golpeo, veo la sangre, me tendría que estar retorciendo de dolor, pero nada, no noto nada).
Parestesias	• Sensaciones erróneas de acuerdo con el estímulo producido. • En este caso el sujeto ante el estímulo sensorial que debía producirle una sensación adecuada a él, le produce una sensación inadecuada. Igual ocurre que si al recibir un pinchazo en lugar de sentir dolor es un hormigueo o frío, etc.
Cenestopatías	• Son sensaciones imprecisas que el paciente refiere tener en sus órganos internos y/o músculos. • Habitualmente son desagradables para él y se queja de malestar interno que no puede precisar con exactitud como lo haría una persona al sentir dolor en una víscera, por ejemplo.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

ANOMALÍAS EN LA PERCEPCIÓN DE LA CUALIDAD DE LOS ESTÍMULOS: Hacen referencia sobre todo, a las visiones coloreadas, a la mayor o menor nitidez y detalle de las imágenes, aunque también pueden producirse en relación con otros sentidos como el gusto, el olfato, o el tacto.

METAMORFOPSIAS: ANOMALÍAS EN LA PERCEPCIÓN DEL TAMAÑO Y/O LA FORMA:

Metamorfopsias o Dismegalopsias	- La metamorfosis es una alteración en el tamaño o la forma de los objetos que el paciente percibe. - El sujeto refiere que ve las cosas mayores o menores que su tamaño real o sencillamente percibe modificada su forma, ya sea alargada, redondeada, más chata, etc. Macropsias o megalopsias, hace referencia a escala aumentada. Micropsias, hace referencia a pequeña escala.
Autometamorfopsias o alteración del esquema corporal:	Distorsiones en la percepción del tamaño y/o la forma del propio cuerpo. Percibe diferente en cuanto a su estatura o tamaño, a su grosor, a su forma en general o generalmente a alguna porción de su cuerpo, casi siempre a alguna extremidad, su cara o sus genitales.

ANOMALÍAS EN LA INTEGRACIÓN PERCEPTIVA: Se trata de anomalías poco frecuentes, que a veces aparecen en los estados orgánicos y en la esquizofrenia. La persona parece incapaz de establecer los nexos que habitualmente existen entre dos o más percepciones procedentes de modalidades sensoriales diferentes:

Escisión perceptiva	El objeto percibido se desintegra en fragmentos o elementos. Percepción desintegrada de los diversos elementos de un mismo estímulo. Puede ceñirse a las formas “morfosis” o a la disociación entre color y forma “metacromía” - Por ejemplo, cuando está viendo la televisión experimenta la sensación de que existe una especie de “competición”, e incluso conflicto, entre lo que oye y lo que ve, como si ambas sensaciones no tuvieran nada que ver entre sí, o como si procedieran de fuentes de estimulación diferentes y “lucharan” entre sí por atraer su atención. - Las conexiones entre ambas modalidades sensoriales (auditiva y visual) han fracasado, o no se han establecido correctamente, y, por ello, la persona tiene la sensación de que proceden de fuentes diferentes y de que atraen al mismo tiempo sus recursos atencionales
Aglutinación Perceptiva	Percepción unitaria de sensaciones que en la realidad se producen de forma diferenciada. - Consiste en que las distintas cualidades sensoriales se funden en una única experiencia perceptiva. En este caso, la persona tiene dificultades, o es incapaz, de distinguir entre diferentes sensaciones.

ANOMALÍAS DE LA PERCEPCIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTÍMULOS AMBIGUOS: LAS ILUSIONES

Ilusiones	Es una mala interpretación de una percepción real, es decir, la persona interpreta un estímulo real de manera equivocada y se convierte en un error perceptivo. - Para que ocurra la ilusión, el objeto debe encontrarse dentro del campo sensorial del sujeto, o sea, que en el lugar que se encuentra situado, la persona es capaz de percibirlo como un todo con todas sus cualidades. Por ejemplo, cuando, atemorizados por la oscuridad de la noche, en una calle desierta, creemos ver una persona allí donde se mueven algunas ramas por efecto del viento
------------------	---

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Pareidolias	- Se trata de una modalidad especial de ilusión en la cual el individuo proporciona una organización o estructura física y, en consecuencia, otorga un significado específico a un estímulo ambiguo, poco estructurado, sin una forma ni significado concretos y, por tanto, sujeto al juego libre de interpretación y búsqueda de significado. - Ejemplos cotidianos de pareidolia son las “caras” que vemos dibujadas en el perfil de una montaña, en las nubes que observamos, o en las llamas que surgen de una chimenea.
TRASTORNOS DE LA IMAGINACIÓN: ENGAÑOS PERCEPTIVOS. Se caracterizan por no fundamentarse en estímulos realmente existentes en ese momento y que coexisten con el resto de las percepciones “normales”.	
PSEUDOPERCEPCIONES E IMÁGENES ANÓMALAS. Las pseudopercepciones o imágenes anómalas son alteraciones perceptivas que no cumplen las características de las que hemos visto hasta ahora. Estas imágenes anómalas pueden concebirse como imágenes y pueden producirse en ausencia de estímulos o pueden activarse aun cuando el estímulo que las originó ya no está presente.	
Imágenes hipnapómpicas e hipnagógicas	- Se las conoce también como alucinaciones fisiológicas, con base en la etiología que tienen. Estos dos tipos de imágenes se producen estados de seminconsciencia, en donde la persona se encuentra entre el sueño y la vigilia. - Particularmente las imágenes hipnagógicas se originan cuando la persona sale del sueño, lo que sería estar entre el sueño y vigilia. Las imágenes hipnagógicas se originan cuando la persona entra en el sueño, es decir, entre la vigilia y el sueño. - Ambas imágenes son autónomas ya que aparecen sin que el individuo pueda controlarlas
Imágenes alucinoides	- Estas imágenes se caracterizan por ser autónomas y subjetivas, por presentarse sin la presencia del estímulo que las active. - Son originadas de forma interna, cuando se dan en el “espacio negro de los ojos cerrados”. Cuya causa se atribuye a la fiebre con temperaturas muy altas o de manera externa cuya causa sería el consumo de drogas alucinógenas, a pesar de ser muy relacionadas a las alucinaciones en estas imágenes la persona es consciente que reconoce que esas imágenes son creadas por su mente y no existen en realidad.
Imágenes mnémicas y eidéticas	- Estas imágenes se relacionan con los recuerdos de cada persona, que son transformados con base en los deseos que tiene cada persona. - Se caracterizan porque la persona puede crearlos voluntariamente y puede mantenerlos de igual manera, ya que, al momento de no mantenerlos voluntariamente, éstos se van desvaneciendo y así van desapareciendo.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Imágenes consecutivas o postimágenes	- Se conocen como post imágenes ya que estas se presentan después de una alta carga de información sensorial - Además, la imagen que se produce tiene propiedades opuestas a las de la imagen original, hecho por el cual a veces se las denomina “imágenes negativas”: por ejemplo, después de mirar un intenso color oscuro, se ve un color claro, o el movimiento descendente de una cascada se experimenta posteriormente con un movimiento ascendente.
Imágenes parásitas	Se diferencian de las mnésicas porque son autónomas e involuntarias y de las consecutivas por su subjetividad (i. e., la persona sabe que son un producto de su mente). Pero al igual que ellas, se producen como consecuencia de un estímulo concreto que ya no se halla presente cuando se produce la imagen, lo que las distingue de las ilusiones.
ALUCINACIONES: Experiencias similares a la percepción que se producen en ausencia del estímulo apropiado para producir tal percepción con toda la fuerza e impacto de una percepción real y que no pueden ser dirigidas o controladas por quien las está experimentando. El sujeto percibe falsamente un cuerpo que no se encuentra presente en el campo sensorial en el momento de la vivencia , sin que exista sustitución de los cuerpos presentes a su alrededor.	
Según su complejidad	En las alucinaciones complejas se percibe el estímulo concreto, es decir, si se presencia un objeto entonces éste se percibirá muy detallado, mientras que en las alucinaciones elementales se aprecia el objeto de una manera difusa.
Según su contenido	- Los contenidos que pueden abarcar las alucinaciones son infinitos, sin embargo, estos se pueden englobar en temas centrales como serían: las necesidades del individuo, donde se encontrarán subtemas como recuerdos, temores, deseos, entre otros. O los contenidos del entorno de la persona como la influencia de sus ideologías que crearían inseguridad, vergüenza, entre otros. - Adicional y relacionado a la posición de la persona en el ambiente se encontrarán las circunstancias vitales y extremas de la persona, ya que, por ejemplo, una persona a la que mantienen en la cárcel tenderá a alucinaciones con verdugos, por ejemplo.
Según la modalidad sensorial	Se refiere a la vía por la cual la alucinación se evidencia. En la mayoría las alucinaciones se presentan de forma visual o auditiva, sin embargo, existen más vías, a las que se hará referencia a continuación: Vía visual. Una alucinación visual es aquella que se produce a través de la vista, tiene las siguientes subdivisiones con base en el tamaño, a la temática, etc.: ➤ Según la temática: alucinaciones relacionadas a un tema específico. – Zoopsias: alucinaciones relacionadas con los insectos. – Delirium Tremens: alucinaciones relacionadas con multitud de temáticas, debido a síndrome de abstinencia alcohólica. ➤ Según el tamaño: alucinación donde las cosas son más o menos grandes. – Alucinación liliputiense: alucinación donde los objetos se ven diminutas o más pequeñas de lo normal. – Alucinación guliveriana: alucinación donde los objetos se ven enormes, o más grandes de lo normal.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

➤ **Según las cualidades:**

- **Intensidad:** Muy borrosa o densa.
- **Color:** Alucinaciones en escala de grises, alucinaciones de un solo color, transparentes, etc.
- **Movimiento:** alucinaciones estáticas o está en movimiento.
- **Extensión:** Lo que ocupa. Ej. Una clase llena de personas que no hablan.
- **Posición:** Ver las cosas donde no están. Ej. Ver un loro sobre un pico.
- **Binoculares o monoculares:** Con un ojo o con los dos.
- **Congruencia o incongruencia:** alucinaciones congruentes en las cuales tienen relación con la realidad o incongruentes en donde no tienen coherencia con la realidad. Ej. Un tren volando, un perro en bicicleta.

Existen **alucinaciones visuales relacionadas con el cuerpo del sujeto**, se denominan **autoscopia**. Entre éstas se encuentran: **la autoscopia interna**, que se da cuando una persona ve el interior de su cuerpo. Ej. Venas, huesos, vísceras... Encontramos también la **autoscopia externa**, que se da cuando alguien ve la imagen de sí mismo frente a él. Por último, tenemos la **autoscopia negativa** que se da cuando alguien no se ve, o no ve su imagen reflejada en un espejo.

- **Auditivas.** Las alucinaciones auditivas son **aquellas cuya vía es la audición**, es decir, en estas alucinaciones la persona **“escucha” un estímulo inexistente**. Este tipo de alucinaciones es el más frecuente conjunto a las alucinaciones visuales. Las alucinaciones auditivas según su grado de complejidad pueden presentarse como **elementales**, en donde la persona **escucha tonos, pasos o murmullos**. Mientras que en una alucinación **auditiva compleja**, la persona **escucha palabras claras y con significado**.

Entre las variables para subdividir este tipo de alucinaciones se encuentran:

- **Claridad:** claridad con la que se percibe
- **Intensidad:** la magnitud de este estímulo irreal Ej. susurros, gritos, entre otros.
- **Localización:** distancia a la que se percibe. Ej. Cerca, lejos.
- **Contenido:** Estímulos simples o complejos, a continuación, se presentan ejemplos de estas.
 - Reveladores de cierta información. Ej. la persona que escucha voces que le dicen cosas como dónde está el bastón de su abuelo.
 - Voces que piden.
 - Voces que ordenan.
 - Comentarios sobre actos que realizan.
 - Propositiones eróticas de tipo grosera.
 - Voces amenazantes

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	➤ Modos de dirigirse a la persona. términos y elementos del lenguaje utilizados. Ej. Monosílabos. Gritos, susurros, etc. • Olfativas. Alucinaciones en donde la persona huele, desde cosas agradables a nauseabundas. Es habitual que estén asociadas a envenenamientos, tumores cerebrales, cuadros clínicos en donde las personas creen estar siendo envenenadas, entre otros. De esta manera los pacientes consideran estos olores los agreden, o consideran son parte de una persecución que busca causarles un daño. • Gustativas. Este tipo de alucinaciones crean en los pacientes la experimentación de gustos desagradables, y las relacionan con creencias de ser envenenado, pero es difícil saber qué es verdaderamente una alucinación debido a que en la vida diaria beber o comer algunos medicamentos o comidas pueden alterar el gusto. En algunos casos se presentan como causadas por su propio cuerpo, en donde el sujeto atribuye la idea de estar pudriéndose por dentro. • Táctiles. Estas alucinaciones se pueden presentar por todo el cuerpo. El sujeto puede sentir pellizcos, tocamientos, corrientes eléctricas, quemaduras, entre otros. De esta manera, en función del contenido de cada una de estas se pueden distinguir: ➤ Hápticas: sensación física. Ej. Cosquilleos. ➤ Hídricas: sensación de humedad. ➤ De contacto: tocar ➤ Cinestésicas: cuando un individuo dice que una parte de su cuerpo se está moviendo. Determinada por otra sensación subjetiva que afecta a un sentido diferente. ➤ Activas: cuando la persona tiene la sensación de tocar, es decir, la persona cree, por ejemplo, que ha tocado un objeto inexistente como tener la sensación de estar tocando insectos, etc. ➤ Pasivas: cuando la persona tiene la sensación de ser tocada. El paciente cree que hay alguien o algo que le está tocando, quemándole o pinchándole, etc.
División adicional de alucinaciones	• Existe una división adicional de alucinaciones conocidas como nueva variante y hasta se consideran trastornos de la representación ya que por ejemplo “la pseudoalucinación no tiene corporeidad y aparece en el espacio subjetivo interior, rasgos esenciales que la distinguen de la alucinación verdadera” (Capponi, 2013, p. 54). Entre estas se encuentran: ➤ Pseudoalucinaciones: La diferencia que la percepción errónea se encuentra fuera del campo perceptual del sujeto enfermo. O sea, que el objeto se percibe allí donde normalmente no puede percibirse. Ejemplo: un paciente se queja de oír voces dentro de la cabeza, o ver un animal dentro de su estómago. ➤ Alucinosis: La persona es consciente de que lo que percibe no existe. Ej. Alguien que ha tomado drogas. ➤ Alucinación negativa: La persona no percibe un estímulo que si existe.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

OTRAS ALTERACIONES DE LA PERCEPCIÓN:

Desrealización	• Percibe los objetos con la misma nitidez que antes, pero le parece que no existen, no puede precisar si verdaderamente son reales. • Tiene conciencia de que lo que percibe se corresponde a la realidad. Generalmente estos pacientes dicen que “notan las cosas raras, como si no existieran, como si todo a su alrededor fuera una fantasía”.
Despersonalización	• Vivencia de extrañeza o de cambio del Yo, en la que el sujeto se percibe como si no fuera real, caracterizada por pérdida de espontaneidad de los actos, del pensamiento y de los sentimientos, así como vivencia de conducta automática. • Sentimiento de extrañeza y de estar alejado de uno mismo, sensación de pensar y percibir como si fuera otra persona y de que puede salir del cuerpo y verse a sí mismo, impresión de que las palabras y los pensamientos ven desde fuera
Transformación	• Percibe él mismo como si no fuera él, considera que es otra persona. Ha perdido su identidad propia para convertirse en otro sujeto, habitualmente relacionado con algún personaje destacado en el campo de la cultura, deportes, política, la ciencia, etc.

PSICOPATOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

El pensamiento es el proceso cognitivo que nos permite elaborar y desarrollar ideas, en donde se aplican una serie de capacidades, como la evaluación, creación, planeación, imaginación, etc. Este sistema sufre de constantes alteraciones debido al conjunto de percepciones y representaciones que son entrelazadas mentalmente, ya que la atención no suele permanecer fijamente dirigida a un objeto, sujeto o idea específica (Bonilla, 2013).

ALTERACIONES DEL ORIGEN DEL PENSAMIENTO:

Pensamiento autista	• El pensar se origina a partir de vivencias preceptuales que no se corresponden a la realidad. Es un pensamiento lleno de fantasía y de irrealidad. • Generalmente surge a partir de una sensación o percepción anormal, habitualmente alucinatoria. • A estos pacientes se les ve “ensimismados” en su mundo irreal, apartados de la realidad, “viviendo” su mundo fantástico. Esto es lo que llamamos autismo o pensamiento autista
----------------------------	---

ALTERACIONES DE LA FORMA, CURSO O ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO:

Bradipsiquia lentificación del pensamiento	• Retardo o la lentificación en la producción de las ideas. • La paciente conversa muy lentamente, cuando le dirigimos una pregunta, demora en contestar y cuando lo hace, su diálogo se torna tediosos, como si tuviera que hacer un tremendo esfuerzo para coordinar sus ideas. • Este síntoma es frecuente en pacientes portadores de cuadros depresivos graves.
---	---



PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Taquipsiquia o aceleración del pensamiento	• Es lo opuesto del anterior. • Se caracteriza por el desarrollo rápido de las ideas. Los pacientes responden las preguntas muy rápido u su conversación es acelerada y habitualmente muy rica en palabras y expresiones. • Este síntoma es característico de los cuadros de manía.
Fuga de ideas o descarrilamiento	• Es el grado máximo de aceleración del pensamiento. • El paciente “piensa más rápido de lo que es capaz de transmitir mediante el lenguaje”. • Las ideas “se le fugan” al paciente y no puede concluir la idea que estaba expresando.
Pérdida de meta	• En este caso se produce un fracaso a la hora de seguir una cadena de pensamientos hasta su conclusión. Se trata de un discurso que comienza con un tema concreto, pero empieza a divagar y se va alejando paulatinamente del asunto inicial hasta el punto de que no se vuelve a él. • El paciente puede darse cuenta, o no, de que ha perdido su meta, lo que quería decir. Su aparición se suele asociar con el descarrilamiento.
Prolijidad	• Detallismo en la conversación • Sin que tenga aceleración de su pensamiento, al hablar, da muchos rodeos innecesarios, haciendo alusión a hechos y sucesos que no tienen tanta importancia pero que se relacionan con la idea central de lo que quiere expresar. • Este síntoma es frecuente en pacientes que son portadores de enfermedades como las demencias y trastornos obsesivo-compulsivos, que estudiaremos más adelante.
Perseveración	• Repetición automática y frecuente de representaciones verbales y motoras, introducidas por el sujeto como material de relleno cuando se dan déficit de evocación, el paciente insiste en la idea y la repite una y otra vez. • A veces se trata de una idea, frase o simplemente palabra que se repite durante el diálogo de forma reiterativa e innecesaria.
Bloqueo o Interrupción del pensamiento	• También se le llama robo del pensamiento. • Caracterizado porque el paciente en su conversación de pronto se detiene sin haber terminado la idea central, manifestando que “se le fue la idea de lo que estaba diciendo”
Vacío mental	• El paciente manifiesta que no piensa en nada, que tiene la mente en blanco. Se suele presentar en pacientes con depresión y demencias.
Verborrea	• El individuo habla por horas o por días, intentando expresar sus ideas, pero sin poder lograrlo –lo que dice carece de significado–. • Puede estar hablando solo o con otras personas, también puede tener un tono alto al hablar o muy bajo (murmullo). Asociado a procesos orgánicos, psicóticos o maníacos.
Disgregación	• Existe es una incongruencia en las frases que dice el paciente sin que una tenga relación con la otra. • Por ejemplo: un paciente dice ¡la naranja es dulce y sabrosa, pero yo me quedo en la casa porque la silla está en su sitio”.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Aliteración	El paciente repite una o muchas letras en una sola frase de manera innecesaria.
Incoherencia, Esquifofasia o Paragramatismo	Falta de conexión lógica entre las palabras que componen una frase y que se hace totalmente incomprensible para el interlocutor. - Verdaderamente lo que se produce es una “ensalada de palabras” y podríamos decir que hay una ruptura del pensamiento del paciente.
Tangencialidad	Cuando se le realiza una pregunta al paciente, éste responde oblicuamente, es decir, con respuestas tangenciales o incluso irrelevante.
Illogicidad	- Patrón de habla en el que no se llega a las conclusiones de manera lógica. - Es un fracaso en las inferencias inductivas.
Habla distraída	- Este trastorno es especialmente frecuente en la manía y, en un grado mucho menor, en estados de ansiedad. - Se caracteriza porque durante el discurso la persona se detiene en medio de una frase o idea, y cambia de tema en respuesta a estímulos inmediatos y nuevos (p. ej., lo que hay sobre la mesa del clínico).
Neologismos	- En este caso la persona inventa palabras o bien otorga un significado diferente del correcto a una palabra del lenguaje cotidiano. En consecuencia, el oyente no comprende lo que está diciendo el paciente que, a menudo, acaba también por perderse en su discurso. - Es muy poco frecuente y solo aparece ocasionalmente en algunos casos de manía y esquizofrenia. Ejemplo: En las meserías se asientan las orugas como si fueran aspirides.
Autorreferencia	- El paciente lleva constantemente el discurso hacia sí mismo de manera inadecuada, aunque se trate de un tema neutro. - Es difícil de valorar en el contexto de una entrevista clínica donde las preguntas se refieren continuamente a la persona, es más fácil hacerlo en una conversación informal sobre aspectos neutros u observando cómo se comporta el paciente en las relaciones con otros. Ejemplo: Entrevistador: ¿Qué día de la semana es hoy? Paciente: Martes. Justamente ese es un gran problema para mí, nunca tengo claro qué día es. No se debe confundir con un delirio de referencia, en el que el paciente se siente amenazado o minusvalorado a partir de cualquier comentario inocuo que escuche, ya sea sobre él o sobre cualquier otro tema, o ante cualquier pregunta que se le haga durante una entrevista.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Pobreza del habla o alogia	• Consiste en una disminución de la cantidad de lenguaje espontáneo. La persona responde a las preguntas de forma breve, concreta y poco elaborada, sin añadir información adicional de manera espontánea. • Las respuestas pueden ser, de hecho, monosilábicas e incluso puede que el paciente no responda a alguna de las preguntas. • Ejemplo: Entrevistador: ¿Tienes hermanos? Paciente: Sí. (Habitualmente, ante preguntas de este tipo se suele añadir algún detalle, como por ejemplo, «sí dos chicas más jóvenes que yo y un chico mayor que yo»).
Pobreza del contenido del habla (pobreza del contenido del pensamiento, habla vacía, alogia, verbigeración, trastorno formal negativo)	• El paciente responde tomándose un tiempo normal, e incluso algo superior, pero el contenido que se transmite es escaso y poco informativo. • También puede suceder que el paciente proporciona la información adecuada, pero necesita muchas palabras y tiempo para proporcionarla. • Ejemplo: Entrevistador: ¿Por qué elegiste leer precisamente esta novela? Paciente: Porque me gusta leer, leer es bueno. Mi padre siempre dice que le gusta leer, a mí me gusta leer. Cuando leo me gusta. También me gusta leer con mi padre. La novela es una forma de literatura muy interesante. Me gusta mucho.
OTROS TRASTORNOS FORMALES DEL PENSAMIENTO	
Pararrespuestas o respuestas aproximadas	• Se evidencia cuando, ante una pregunta concreta que entra dentro de los conocimientos del paciente, este proporciona una respuesta aproximada que indica que ha comprendido la pregunta, pero su respuesta no es correcta ni exacta, o guarda solo una relación muy indirecta con la pregunta: • Por ejemplo, ante la pregunta de “¿cuántos años tiene?”, el paciente responde: “con mi madre y mis dos hijas sumamos 152”
Pensamiento concreto (concretismo)	➤ Hace referencia a un pensamiento excesivamente concreto y literal, con dificultades para la abstracción o para captar el significado metafórico del lenguaje, interpretando las metáforas en sentido literal: por ejemplo, un paciente al que se le indica que la medicación que está tomando puede tener efectos secundarios, intenta ser siempre el segundo en cualquier actividad del hospital.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

ALTERACIONES DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO:

PENSAMIENTOS REPETITIVOS NEGATIVOS: Pensamientos intrusivos, de elevada recurrencia, incontrolables, y de contenido negativo.

Preocupación (worry)	➤ Cadena de pensamientos sobre el futuro, cargada de afecto negativo, relativamente incontrolable. Representa un intento de resolución mental de problemas con resultado incierto, aunque con alta probabilidad de que sea negativo. ➤ Ejemplo: "Siempre me he preocupado por todo, qué prepararía para cenar, qué suéter me combinaba mejor, o cuál sería el mejor regalo para cualquier amigo. Simplemente no puedo despreocuparme de ningún detalle. Si estaba demasiado preocupado, dejaba de ir al trabajo. Entonces me preocupaba por perder el trabajo. Siempre me he imaginado que las cosas serían peores que la realidad"
Rumiación	➤ Proceso de pensar de forma perseverante o repetitiva sobre las emociones negativas, los síntomas de malestar y los problemas, así como en sus posibles causas y consecuencias. Más orientada hacia el presente o el pasado reciente que hacia el futuro. ➤ Ejemplo: "Siento que todo el día estoy dándole vueltas a las cosas que hice mal, y en las que podía haber hecho para no llegar a esta situación en la que ahora me encuentro... ¿qué hice mal? ...todo el tiempo me siento mal, sin ganas de nada, intento entender el porqué, pero no lo consigo, lo pienso una y mil veces, vueltas y más vueltas sobre lo mismo, no consigo librarme de esto, es como estar en un túnel, sin salida... He fallado a todo el mundo, empezando por mí mismo..."
Pensamientos automáticos negativos (PAN)	➤ Auto-afirmaciones negativas, auto-depreciativas, breves, repetitivas, que aparecen de forma repentina en el flujo de pensamientos. No guardan relación con la búsqueda de soluciones acerca de los problemas. ➤ Ejemplo: «No soy bueno». «Por qué no puedo hacer nada bien». «Me siento incapaz de empezar de nuevo» «Mi vida es un desastre» «Soy un inútil, no valgo para nada».
Obsesión Idea obsesiva	➤ Característica de la idea fija y fóbica de no poder apartarla cuando se produce a pesar de los esfuerzos que haga el paciente para hacerlo, o sea, es una idea parásita y morbosa, sin embargo, por su contenido, tiene la característica de ser absurda, ilógica y el propio paciente la reconoce como tal. ➤ Pensamiento, Impulso o imagen recurrente y persistente que se experimenta como intrusa o no deseada y que causa ansiedad o malestar significativos, por lo que la persona la intenta ignorar o suprimir de algún modo. ➤ Las principales características de las obsesiones son las siguientes (Clark y Rhyno, 2005): ➤ Cualidad intrusa: Los pensamientos, imágenes o impulsos irrumpen de forma repetitiva, involuntaria y súbita en el flujo del pensamiento consciente en contra de la voluntad de la persona. ➤ Recurrencia: En la mayoría de los casos, cuando los síntomas se dan en su máxima expresión, las obsesiones se producen a diario, durante amplios períodos de tiempo.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	➤ Inaceptabilidad: Las obsesiones son valoradas por los sujetos como inaceptables, y el afecto negativo que evocan varía desde la molestia al malestar o el miedo y la ansiedad. ➤ Irracionalidad: La persona reconoce, en algún momento, que la idea obsesiva no tiene sentido, que es irracional. Muchos pensamientos obsesivos son valorados por el sujeto como ideas absurdas, carentes por completo de justificación racional. Esta valoración puede diferir en diferentes momentos del trastorno y en diferentes pacientes. ➤ Resistencia activa: Son extremadamente habituales los intentos voluntarios de suprimir, eliminar, disminuir o evitar que la obsesión entre en el flujo de pensamiento por medio de la evitación, de estrategias de control cognitivas o de comportamientos repetitivos (compulsiones). ➤ Incontrolabilidad: Los intentos de supresión están condenados al fracaso porque la idea obsesiva es muy difícil (o imposible) de controlar voluntariamente. ➤ Modalidad de aparición: Una obsesión puede tomar la forma de imagen mental, de impulso (necesidad imperiosa y urgente de hacer o decir algo, sin que se lleve a cabo la conducta), de pensamiento (verbal, en forma de palabras o frases, de duda, de idea, prohibición), y/o de sensación de que «algo no está bien». ➤ Egodistonia: Las obsesiones se definen como egodistónicas, es decir, resultan contradictorias con, o contrapuestas a nuestro bienestar porque afectan a nuestro propio «yo».
Obsesiones autógenas	• Ideas obsesivas con contenidos agresivos, sexuales, religiosos o inmorales, que resultan muy desagradables, son egodistónicas, y están poco relacionados con los estímulos que las suscitan.
Obsesiones reactivas	• Ideas obsesivas sobre contaminación, errores, simetría y orden, cuyos contenidos son valorados como racionales y lógicos pero sus posibles consecuencias resultan muy amenazantes y suscitan comportamientos dirigidos a evitar o minimizar tales consecuencias (p. ej., lavar, ordenar, contar, repetir, comprobar).
Pensamientos intrusos	• Ideas fenomenológicamente similares a las obsesiones: repetitivas, intrusivas, no deseadas, no intencionadas, interfieren con las actividades, se asocian con afecto negativo, y son difíciles de controlar. • Pueden versar sobre cualquier contenido (p. ej., contenidos obsesivos, alimentarios, sobre defectos en la apariencia, hipocondríacos) y son comunes en la población general sin trastornos mentales.
Ideación autolítica	• La ideación autolítica o suicida consiste en pensamientos sobre lesionarse físicamente o matarse. Estos pensamientos fluctúan en cuanto a su persistencia y recurrencia y se asocian a estados afectivos negativos e intensos: especialmente, tristeza, ira, culpa, frustración y ansiedad.
Creencia disfuncional o distorsionada	• Supuestos, juicios y valoraciones que se asumen como ciertas, verdaderas o muy plausibles, independientemente de un suceso o situación concretos, y sesgan el procesamiento de información nueva en un sentido que es improductivo y negativo para la persona.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Idea sobrevalorada	• Exceso de valoración o de importancia de un asunto que realmente no lo tiene. • Por ejemplo: una persona tuvo una pequeña discusión de trabajo con otra. Terminada la misma, el asunto queda aclarado y totalmente solucionado, sin embargo, ella sigue pensando que el problema ha sido grave y e incluso llega a darle tanto valor que cree que por lo ocurrido va a ser sancionada o amonestada.
Idea fija	• Refleja un fenómeno real y además lógico, sin embargo, aparece en el campo de la conciencia del individuo persistentemente y en contra de su voluntad. • El paciente refiere que no puede apartar de su mente un pensamiento o una idea y aunque haga un esfuerzo para apartarla, no lo logra.
Idea fóbica	• Refleja miedo o temor • El paciente comprende que ese miedo que siente no tiene fundamento pues analiza que lo que se lo produce no es una causa para que lo sienta, sin embargo, aunque trate de apartarlo de su mente, no puede hacerlo. • El encontrarse en un lugar cerrado como elevadores, guaguas llenas de pasajeros, habitaciones cerradas, etc. En este caso hablamos de una claustrofobia. • Hay otras situaciones comunes en la cotidianidad como el cruzar una calle muy espaciosa, o permanecer en una plaza grande estando vacía de otras personas, etc. Este temor a los espacios abiertos se denomina agorafobia
Idea hipocondríaca	• Aqueja molestias diversas procedentes de su organismo que él interpreta, pudieran ser producidas por alguna enfermedad. • Acuden con frecuencia al médico buscando se les diagnostique alguna enfermedad y se someten a investigaciones paramédicas diversas para lograr su convencimiento.
Idea delirante. Falsa imagen de un hecho que no se ha producido o la deformación de	• Decimos que el delirio es irreal porque el pensamiento que tiene el paciente no es como realmente él cree, no es verdadero. Es ilógica por lo absurdo que su contenido tiene. Es morbosa porque se hace pertinaz, constante, el individuo que la posee no puede apartarla de su mente y se convierte verdaderamente en un morbo. Es, además, irreductible puesto que, aunque intentemos por medio del convencimiento de lo que él piensa es irreal, ilógico, no logramos convencerle. ➤ De daño o perjuicio: Cuando el contenido se refiere a algún daño para el propio paciente, tal y como pusimos en el ejemplo. ➤ De persecución: Cuando se refiere a vigilancia, chequeo o persecución de su persona. El enfermo refiere que lo vigilan, lo siguen a todas partes, lo tienen chequeado, etc. ➤ De influencia: Cuando existe una fuerza externa imaginaria que influye en el pensamiento del paciente. Habitualmente estos enfermos refieren que le están controlando la mente, todo lo que él piensa, a veces por “una fuerza sobrenatural”, otras por “aparatos especiales”, otras por “telepatía”, etc. ➤ De grandeza, megalomaniacas o expansivas: Cuando expresan una exaltación de las cualidades personales del individuo. A veces estos enfermos creen ser grandes personajes, haber hecho descubrimientos o inventos que lo han hecho famosos, que tienen relaciones directas con el presidente de la república, etc. A este tipo de delirio también se le llama expansivo.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

un suceso que sí ocurrió.	➤ De referencia: Cuando el contenido del pensamiento del paciente se refiere a que las demás personas que le rodean hablan mal de él, se ríen o burlan de él, etc. Ellos manifiestan que cuando pasan por un grupo de personas piensan que lo que están hablando se refiere a ellos, o si se ríen, es porque lo hacen de ellos. ➤ Eróticas: El sujeto se cree amado profundamente por otra persona, generalmente más importancia en rango, conocimientos, fama, que él. ➤ Celotípicas: Caracterizadas por la creencia delirante de que su pareja lo engaña, que mantiene relaciones ocultas con otra persona. Este tipo de idea generalmente se presenta de forma única, bien estructurada, la personalidad del sujeto se mantiene indemne y fuera del tema delirante mantiene una ideación y conducta normales, nos lleva de la mano al diagnóstico de una paranoia. ➤ De autorreproche: Cuando el paciente considera haber cometido algún delito grave, haber hecho algo de lo que se siente arrepentido y culpable. En estos casos realmente el individuo no ha cometido ninguna falta o delito, pero él asegura que sí y esto le remuerde la conciencia y le hace sufrir. ➤ De nihilismo o nihilistas: Cuando el paciente manifiesta que se siente su propio cuerpo muerto, como si hubiera dejado de existir. A veces esa sensación de muerte o destrucción se proyecta hacia las cosas o personas que le rodean. Estas ideas, al igual que las de autorreproche se ven en pacientes con cuadros depresivos graves. ➤ De negación: Este tipo se presenta cuando en enfermo piensa que todo a su alrededor está muerto, vacío, no existe, incluso el tiempo y él mismo, lo que paradójicamente le confiere cierto nivel de “inmortalidad”. ➤ Hipocondríaca: Cuando las manifestaciones hipocondríacas no son reductibles a través de la lógica del examen médico, los complementarios indicados, etc. Se ven con frecuencia en los cuadros depresivos psicóticos. ➤ Mística-religiosa: Idea delirante relacionada con creencias de naturaleza religiosa, que se pueden presentar en el contexto de un sistema religioso convencional (p. ej., posesión por el demonio), implicar un sistema religioso nuevo, o basado en una mezcla de creencias extraídas de una variedad de religiones (p. ej., ideas sobre la reencarnación o el nirvana). El delirio religioso puede combinarse con delirios de grandeza (p. ej., el paciente que se considera Dios, o un líder religioso), de culpa o de control. ➤ De pobreza o ruina: Idea delirante de que se ha perdido, o se perderán, todas o casi todas las posesiones materiales, de que se encuentra en un estado de pobreza extrema y que todo ello va a llevar también a la ruina a su familia. ➤ De suplantación: Se trata de una falsa identificación delirante según la cual el paciente cree que una persona importante en su vida (p. Ej., su pareja) está siendo usurpada por un impostor que tiene exactamente la misma apariencia, siendo un doble exacto: por ejemplo, el paciente que no reconoce que la persona que se queda a todas las noches dormir con él en el hospital es su pareja.
Ideas deliroides:	• Tienen características similares a las delirantes, pues son morbosas o insidiosas, son irreales, ilógicas, pero al hacer razonar • al enfermo acerca de lo ilógico de las mismas, puede reconsiderarlas y comprender que pudieran estar producidas por un estado de ánimos de él mismo.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

PSICOPATOLOGÍA DEL LENGUAJE Y HABLA

Comenzando por las alteraciones del lenguaje y el habla, éstas representan un deterioro o un desarrollo deficiente de la comprensión o utilización de un sistema de símbolos (Ramos y Manga, 2008) y en muchos casos se producen como resultado de una lesión cerebral.

Afasia	• Trastorno del lenguaje que sobreviene como consecuencia de una lesión cerebral. Se define la afasia como la perdida de la capacidad de producir o de comprender el lenguaje en cualquiera de sus formas -lectura, escritura o habla- debida a traumatismos o enfermedades de los centros cerebrales implicados en el lenguaje. • Existe acuerdo en cuanto al carácter focal, y no generalizado o difuso, de las lesiones cerebrales que la originan. Por el contrario, hay desacuerdo sobre la descripción de la naturaleza de la afasia y qué trastornos lingüísticos deben incluirse bajo dicho término. Los síndromes afásicos pueden tener un origen cortical y/o subcortical.
Agramatismo	• Dificultad para encadenar palabras en frases utilizando las reglas gramaticales
Aprosodia	• Incapacidad para la entonación, musicalidad, inflexión y cadencia del habla
Agrafia	• Pérdida en la capacidad ya adquirida para el lenguaje escrito
Alexia	• Pérdida en la capacidad ya adquirida para la lectura
Anomia	Dificultad para encontrar palabras que designen objetos o personas
Dislalia	• Dificultad para articular fonemas, sílabas o palabras [dislalia fonética]. Puede ser debida a alteraciones orgánicas [labio leporino, macroglosia, fisura palatina, rinolalia, déficits auditivos) o funcionales. • Estas últimas son las más frecuentes. Cuando la dificultad es para identificar y reproducir los sonidos de la lengua se la denomina dislalia fonológica.
Disfasia evolutiva (trastorno específico del lenguaje).	• La disfasia evolutiva es un trastorno específico del lenguaje que afecta tanto a la expresión como a la comprensión. Se da en niños de inteligencia normal, que no han adquirido aún el lenguaje y que no presentan ningún tipo de alteración sensorial, neurológica, emocional ni carencia ambiental. • En la actualidad también se conoce como trastorno específico del lenguaje (TEL).
Disartria	• Dificultad del habla debida a trastornos del tono y del movimiento de los músculos que controlan la articulación y que son secundarios a lesiones del sistema nervioso.
Disglosia	• Trastorno en la articulación de fonemas por alteración o daño de los órganos periféricos del habla (paladar, lengua, labios, etc). También se conoce como Dislalia orgánica.
Disfonía	• Trastorno de la voz. Abarca tanto las alteraciones cualitativas como cuantitativas de la voz. Puede ser orgánica o funcional.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Parafasia	• Producción no intencional de sílabas, palabras o frases durante el habla. Se diferencia del defecto articulatorio en que en las parafasias algunos sonidos se sustituyen por otra cuya articulación es correcta. • Si se sustituyen sílabas se trata de una parafasia literal o fonémica, que puede devenir en neologística en los casos en que las nuevas expresiones resultantes de los cambios constituyan verdaderos neologismos en el idioma afásico. Si el paciente cambia una palabra por otras (por ejemplo, «guante» por «zapato») nos hallamos ante una parafasia verbal.
Mutismo	• Ausencia permanente del lenguaje expresivo o desaparición temporal o permanente de éste en un sujeto que lo ha adquirido previamente. Puede relacionarse con causas psicológicas y emocionales, funcionales, estructurales o mixtas. • Se encuentran casos de mutismo permanente en cuadros de autismo infantil, psicosis regresivas y deficiencia mental profunda.
Mutismo selectivo	• Cuadro clínico que se caracteriza porque el sujeto se niega a hablar ante determinadas personas o situaciones. • Aparece entre los 3 y 7 años, coincidiendo a veces con la iniciación del niño en la vida escolar. • Suele manifestarse sin asociación de otras alteraciones, a no ser la de negarse a ingerir alimentos. Para algunos autores es un trastorno de ansiedad de tipo obsesivo-compulsivo; para otros es un trastorno psicótico o prepsicótico. Se denomina también mutismo electivo o mutismo parcial.
Tartamudez	• Alteración en la fluidez y en el patrón del habla, inapropiadas para la edad del individuo y persistentes a través del tiempo. • El patrón de habla del tartamudeo se caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos del habla, a las que se denominan «disritmias» o «disfluencias». La fluidez, el tiempo y el ritmo del habla, al estar alterados, dificultan las posibilidades de comunicación del sujeto.
Coprolalia	• Se trata de la emisión involuntaria de palabras obscenas o insultantes, que no se dirigen a un oyente concreto con intención o voluntad de agraviar o molestar. • Pueden producirse al inicio del discurso (p. ej., al responder a un saludo o a una pregunta concreta) o aparecer en el transcurso del habla normal. • La persona se da cuenta de la aparición de estas palabras y se avergüenza de ellas.
Ecolalia	• Forma parte del grupo de los “eco-síntomas” que consisten en que el paciente repite como en un eco lo que acaba de escuchar, o el movimiento que alguien hizo ante él (ecopraxia), o el gesto del interlocutor (ecomimid). • En su formato verbal, consiste en la repetición en eco de las últimas sílabas, palabras, o frases breves que acaba de pronunciar un interlocutor, o alguien que está cerca del paciente, o de una imitación o reproducción del habla de otra persona que está presente.
Palilalia	• Repetición de una palabra que va incrementándose en su frecuencia • El individuo repite las palabras o sílabas que tienen coherencia con su estado de ánimo o emocional. • Se presentan en personas deprimidas o pesimistas, esquizofrénicas y dementes



PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

PSICOPATOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD

Término más general en la esfera del estudio de las emociones. Se trata de un concepto amplio que incluye emociones, sentimientos, impulsos motivacionales y estados de ánimo.

TRASTORNOS CUANTITATIVOS: Cuando se refieren a la intensidad o magnitud del tono afectivo del individuo. Miden “cantidad”.

Eutimia	Estado de ánimo equilibrado, caracterizado por una sensación de bienestar y tranquilidad
Hipertimia: Aumento del tono afectivo del individuo	Hipertimia placentera: Es la que le provoca un efecto agradable o de placer para el sujeto. La alegría: Es el estado de ánimo placentero normal, cuando existe un motivo o una causa real que la provoque. La euforia: Es un estado de ánimo también placentero, producido por una alegría inmotivada. El individuo está alegre, pero no sabe por qué está alegre. La moria: Es un estado de alegría “insulsa”, “sosa”, que no tiene sentido. Podríamos decir que es una “alegría estúpida, tonta” y puede verse en pacientes con tumoraciones cerebrales o retrasos intelectuales profundos. La hipomanía: Es un estado de exaltación del estado de ánimo o de alegría exagerada, donde el paciente muestra su grado elevado de satisfacción que no siempre concuerda con la realidad que lo circunda. Estos pacientes se muestran muy jocosos, chistosos, en extremo alegres, resultan muy simpáticos a los interlocutores. La manía: Es el grado máximo de exaltación del tono afectivo de un individuo y ese estado siempre se acompaña de una conducta excitada. Estos pacientes suelen ser en extremo inquietos, comienzan una actividad y no la terminan para luego comenzar otra, son en extremo simpáticos. Hacen chistes, se ponen a bailar, cantar, su conducta sexual es exagerada (hipererotismo).
Hipertimia: Aumento del tono afectivo del individuo	Hipertimia displacentera: Es la que provoca disgusto, malestar o desagrado. La tristeza: Es el estado afectivo caracterizado por la insatisfacción de las necesidades de la persona. El estado de ánimo triste lo caracteriza el abatimiento que el paciente nos muestra. Sus fascias son de gran infelicidad y muchas veces nos recuerda a las máscaras que se usaban en el teatro antiguo para hacer las representaciones escénicas.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	- La disforia: Es el estado de mal humor que se traduce por gran irritabilidad. Este mal carácter lleva con cierta frecuencia a conductas agresivas del paciente. Son individuos que se molestan por cualquier cosa, incluso ante situaciones insignificantes. Es frecuente ver la disforia en pacientes con alguna forma clínica de epilepsia, en dementes, otros cuadros orgánicos y durante las depresiones.
Hipotimia: Es el estado de disminución del tono afectivo.	• En estos pacientes todas las reacciones emocionales se encuentran disminuidas. - Indiferencia afectiva: la indiferencia afectiva es la disminución de la reacción emocional de un sujeto ante situaciones que sí deben producirle algún tipo de respuesta afectiva. Estos pacientes no muestran ningún cambio o muy poco cambio en sus expresiones cuando en el medio se produce algún hecho que normalmente debe provocarle agrado, malestar, inconformidad, placer, etc. - Aplanamiento afectivo: podemos decir que el aplanamiento afectivo es el grado máximo de indiferencia afectiva. Es la ausencia de respuesta afectiva, por tanto, estamos en presencia de una atimia (a-partícula privativa, timia-afecto). Estos pacientes se muestran amílicos, o sea, que no tienen ninguna expresión en su mímica o gestos faciales que indiquen cambios en su estado anímico. Hemos visto a un paciente que ante la noticia del fallecimiento de su madre —a la que quería mucho— se ha mantenido totalmente inmutable. No ha mostrado tristeza alguna ni se ha comportado como si la noticia le causara sorpresa siquiera. Estos síntomas son característicos de los procesos esquizofrénicos.
TRASTORNOS CUALITATIVOS: cuando hablamos de las características de ese estado de ánimo, o sea, a sus cualidades o de su “calidad”. Se refieren a las alteraciones del tono afectivo, teniendo en cuenta las cualidades de este.	
Ansiedad	• También llamada angustia. • La ansiedad es una emoción que puede ser definida como respuesta emocional aprendida de naturaleza anticipatoria, que posee un alto valor funcional ya que nos avisa de la posible presencia de un peligro o amenaza y, por tanto, constituye una fuente poderosa de motivación pero que, en determinadas ocasiones, puede llegar a ser desproporcionada, irracional, y desadaptativa • Sentimiento de inconformidad que tiene el sujeto, generalmente de una causa desconocida que se acompaña de cierta inquietud, a veces ligero temblor, lenguaje entrecortado, manifestaciones neurovegetativas tales como enrojecimiento o palidez de la cara, escalofríos, sudoración de manos y pies, a veces más generalizada, erizamiento de los vellos, palpitaciones, etc. la ansiedad tiene sus manifestaciones subjetivas y objetivas: — Las manifestaciones subjetivas de la ansiedad: están dadas por esa sensación, que muchas veces el paciente traduce como opresión en el pecho y que en las personas normales puede observarse en ciertas y determinadas circunstancias tales como: asistir a un examen

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	que vaya a definir nuestra carrera, el esperar un ómnibus en una parada cuando éste se demora y nosotros tenemos prisa, el esperar a una persona que tarda a una cita previamente establecida, etc. esa sensación de desasosiego que experimentamos en esos momentos, es lo que definimos como ansiedad subjetiva. – Las manifestaciones objetivas de la ansiedad: están dadas por todas las alteraciones del sistema neurovegetativo que podemos observar en el paciente y por las alteraciones motoras que ya mencionamos con anterioridad. Las primeras están sometidas a la sensación experimentada por el paciente y que nosotros no podemos comprobar. De ahí su nombre de subjetivas. Las segundas sí pueden ser constatadas por el examinador, tales como el temblor, la sudoración de las manos, la palidez o enrojecimiento de la cara, la inquietud, etc. De ahí su nombre de objetivas. La ansiedad como síntoma, constituye el núcleo central de todas las neurosis, pero también puede verse en otros cuadros psiquiátricos.
Depresión	• Al igual que ocurría con la ansiedad, el término «depresión» puede aludir: a) Una circunstancia anímica (caracterizada por sentimientos de tristeza y decaimiento), adaptativa y frecuente en la vida cotidiana de las personas. b) Un síntoma cuando el estado de ánimo decaído, abatido o triste (disfórico) no es proporcional en intensidad y/o duración a las circunstancias del contexto, estando presente en una amplia variedad de cuadros psicopatológicos y de condiciones médicas. c) Un síndrome o cuadro clínico que constituye un conjunto o patrón de síntomas que covarian entre sí. En este último caso, deben estar presentes otros síntomas distintos del estado de ánimo triste o abatido.
Anhedonia	• Hace referencia a la pérdida de la capacidad para experimentar alegría y placer. • Se trata de una subcategoría dentro de la sintomatología de disminución de intensidad de las emociones. La anhedonia se caracteriza por la incapacidad total de disfrutar de la vida, incluyendo a los acontecimientos u objetos de la vida diaria; una «pérdida de la capacidad para experimentar placer»
Ambivalencia afectiva	• Reacción emocional doble de un sujeto frente a una situación dada, con un sentido contrapuesto. • Como observamos, el paciente tiene dos reacciones emocionales contrapuestas ante un mismo estímulo. De ahí su nombre de ambivalencia.
Disociación o incongruencia ideoafectiva	• También llamada afecto discordante • Reacción emocional contrapuesta a la que habitualmente debe producirle a un sujeto una situación dada. Característicos de la esquizofrenia.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Catatimia	• Estado afectivo intenso hacia alguna persona que es capaz de interferir en la percepción real que sobre la conducta de ese sujeto se pueda tener. Por ejemplo: el afecto inmenso que una madre siente por un hijo le impide aceptar que el mismo es un ladrón o un mentiroso.
Alexitimia	• Este término etimológicamente significa «la falta de palabras para los afectos». • En el lenguaje psicopatológico generalmente se utiliza para describir la incapacidad para identificar o reconocer las propias emociones. • Es decir, la persona muestra una escasa conciencia de sus estados emocionales, confusión respecto a los mismos y, por tanto, dificultades para expresarlos, describirlos y comunicarlos.
Tenacidad afectiva	• Persistencia de un estado afectivo prolongado en el tiempo, más de lo común. En mi criterio se pudiera interpretar como una perseveración afectiva. Por ejemplo, odio hacia alguien que no ha hecho nada tan grave como para merecerlo.
Incontinencia afectiva	• Imposibilidad de contener de forma adecuada las reacciones emocionales • Muchas veces provocadas por situaciones que no tienen esa gran relevancia para el sujeto.
Perplejidad afectiva	• Estado producido por la presencia de extrañeza, desconfianza, falta de comprensión de los sucesos que le rodean al enfermo. Está presente en el estado confusional y a veces en cuadros psicóticos graves.

PSICOPATOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA MOTORA

El comportamiento y la conducta motora de las personas, incluyendo los movimientos, los gestos, y la mímica, están estrechamente interconectados con sus experiencias afectivas y cognitivas, por lo que nos pueden dar mucha información sobre sus emociones, sentimientos, nivel de conciencia, de energía, actitud, o sobre sus pensamientos en un momento determinado.

ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA CONDUCTA MOTORA: En este apartado vamos a describir aquellas alteraciones relacionadas con el comportamiento motor del individuo que varían en un continuo desde la ausencia total de movimiento hasta la actividad excesiva.

ACTIVIDAD MOTORA AUSENTE

Acinesia o aquinesia	• Se define por la pérdida de movimiento o la dificultad para iniciarlo. Esta alteración se caracteriza fundamentalmente por un fallo en el inicio de los movimientos. • La acinesia puede afectar a alguna parte del cuerpo (p. ej., la cabeza, los ojos, los miembros del cuerpo), al espacio de acción (p. ej., reticencia a moverse en una dirección espacial) o a las condiciones de respuesta a los estímulos (p. ej., no conseguir moverse frente a un estímulo específico).
-----------------------------	---

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	La condición médica que se asocia con más frecuencia a la acinesia es la enfermedad de Párkinson, aunque también puede estar presente en otras enfermedades (p. ej., accidentes cerebrovasculares y trastornos neurocognitivos). Esta alteración también puede observarse asociada a trastornos mentales, tales como la esquizofrenia o la depresión mayor.
Parálisis	La parálisis o paresis es la incapacidad para mover alguna parte del cuerpo como consecuencia de una lesión cerebral. La parálisis provoca desgaste y atrofia muscular de la región afectada a consecuencia de la falta de uso. - Las parálisis funcionales afectan al movimiento para realizar alguna acción, por ejemplo, el paciente puede ser incapaz de permanecer de pie y, por tanto, andar y, sin embargo, puede realizar todo tipo de movimientos activos estando sentado o tumbado. - Las parálisis localizadas son aquellas que afectan a un miembro o a una parte de este (p. ej., la mano). La parálisis también puede ser un síntoma del trastorno de conversión, aunque tradicionalmente se la denomina pseudoparálisis para diferenciarla de las que presentan etiología orgánica.
Cataplejía	- El término hace referencia a la pérdida súbita y reversible del tono muscular durante la vigilia (sin alteración de la conciencia). - Suele estar desencadenada por emociones intensas, como la risa, el llanto o la ira, y afecta a ciertos músculos voluntarios, por ejemplo, se cae la mandíbula; la cabeza, los brazos y las rodillas se doblan. - La cataplejía es una alteración que frecuentemente acompaña a la narcolepsia, un trastorno del sueño caracterizado por una somnolencia diurna grave e irresistible.
Catatonía	- Trastorno que incluye varios síntomas: estupor, catalepsia, flexibilidad cética, mutismo, negativismo, perseveración, manierismos, estereotipias, agitación, muecas y ecosíntomas. - También puede ser un especificador de diversos trastornos mentales, estar asociada a diferentes enfermedades médicas, o ser precipitada por los efectos secundarios de algunos medicamentos antipsicóticos.
ACTIVIDAD MOTORA DISMINUIDA Y/O ENLENTECIDA	
Retardo	- El retardo (o retraso) psicomotor o inhibición psicomotriz se caracteriza por anormalidades de la marcha, la expresión facial, los gestos, el habla, la psicomotricidad fina, y los procesos de pensamiento. - Esta alteración implica lentitud en la iniciación, ejecución y finalización de la actividad motora y del pensamiento (bradipsiquia) sin que exista una causa orgánica aparente. - Al paciente le resulta más difícil iniciar y llevar a cabo cualquier actividad, así como pensar, dando lugar a una reducción de la actividad motora espontánea y a mayores latencias de respuesta.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Hipocinesia o Hipoquinesia	- Algunos autores diferencian el retardo psicomotor de la reducción de la actividad motora espontánea o hipocinesia, que recogería la reducción en las actividades que realiza la persona, el hacer pocas cosas (p. ej., dejar de hacer las tareas sencillas del hogar, o en un grado más leve dejar de hacer algunas cosas que antes se hacían como, por ejemplo, quedar con los amigos). - Es una característica asociada a la motivación y a diversas alteraciones como el estupor, los episodios depresivos, la esquizofrenia, o estados de intoxicación. También se puede observar en estados elevados de ansiedad. - Esta lentitud y reducción de movimientos se ha descrito con los términos hipocinesia (reducción de los movimientos voluntarios), y bradicinesia (lentitud en la ejecución de movimientos voluntarios),
Obstrucción	- Se describe como el bloqueo de una actividad motora, y puede manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, la persona puede ser incapaz de iniciar una acción en un momento dado, pero poco después llevarla a cabo sin dificultad; o ante la solicitud de que mueva una parte de su cuerpo puede comenzar a realizar el movimiento y luego detenerse a mitad sin saber cómo continuar; o la persona puede estar realizando una acción voluntaria y detenerse a mitad de forma abrupta. Puede afectar a los movimientos habituales y reactivos, de modo que puede impedir que el paciente se proteja ante una amenaza; así, por ejemplo, un paciente puede permitir que una mosca permanezca en su cara sin espantarla, o no volverse hacia su interlocutor cuando este le habla.
ACTIVIDAD MOTORA EXCESIVA Y/O ACELERADA	
Hipercinesia o hiperquinesia	- También denominada hiperactividad se define como el estado en el que la persona realiza un elevado número de acciones en un corto periodo de tiempo o simultáneamente, sin llegar a completar muchas de ellas. La hiperquinesia se puede manifestar de dos formas habitualmente Hiperquinesia productiva: Cuando la inquietud que presenta la persona es aprovechada para hacer algo productivo. Generalmente estas personas siempre están haciendo algo, pero algo útil y esta forma se asocia a estados habituales de algunos tipos de personalidades o a cuadros de ansiedad. Hiperquinesia improductiva: En este caso la intranquilidad que presenta el sujeto enfermo se traduce en movimientos que no cumplen un fin específico. Caminan por la casa o la sala del hospital de un lado a otro sin un objetivo, si se sientan se mecen constantemente, aunque sea en una silla o mueven las piernas, etc.
Agitación	- Este término se aplica cuando la hipercinesia es extrema y, a diferencia de esta, los movimientos carecen de objetivo. El paciente puede informar de una sensación de tensión o inquietud interna, que efectivamente coincide con una elevada frecuencia de movimientos, a menudo repetitivos, desorganizados o incoherentes, como caminar muy rápido, moverse nerviosamente incapacidad para permanecer sentado, o retorcerse las manos, entre otros. - Atendiendo a la etiología de la agitación, esta se puede clasificar en tres categorías

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	➤ Agitaciones reactivas: Se dan como consecuencia de situaciones o acontecimientos estresantes, de factores tóxicos como efectos secundarios de medicamentos, y de intoxicación y abstinencia a drogas. ➤ Agitaciones en trastornos orgánico-cerebrales: Son aquellas que aparecen en cuadros confuso-oníricos como el delirium tremens, en las crisis de la epilepsia, y como consecuencia de infartos o traumatismos cerebrales. ➤ Agitaciones psicóticas: Estas se observan en la esquizofrenia con catatonia, cuando el paciente sale de la fase de estupor con una crisis de violencia, gritando, corriendo, haciendo muecas o moviendo las extremidades -fenómeno conocido como raptus- también pueden darse en la manía, asociada a la euforia patológica y la expansividad; y en la demencia, donde se observan estados de agitación asociados a la pérdida del sentido crítico y de la comprensión de las situaciones.
Inquietud	• Se trata de un nivel leve de hiperactividad, donde los movimientos no tienen un objetivo. • En este estado el paciente mantiene cierto control sobre su conducta. Al igual que la hiperactividad, la inquietud se observa en estados de ansiedad y en pacientes con depresión con características mixtas, y también puede ser un efecto secundario de los neurolépticos.
Interceptación cinética	• Es la interrupción brusca y sin motivos de un movimiento en fase de ejecución, sin haber logrado la finalidad o meta de este. • Es como si se tratara de una película de vídeo a la que se le coloca pausa, al poco rato el movimiento se reinicia, como si le diéramos play de nuevo.
ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA CONDUCTA MOTORA: En este apartado incluiremos en primer lugar alteraciones que podemos valorar tras solicitar al paciente que desarrolle una actividad; en segundo lugar, otras que no están bajo el control voluntario de la persona, y, por último, un conjunto de comportamientos que sí están bajo el control voluntario y que se realizan con un fin.	
ALTERACIONES DE LOS MOVIMIENTOS INDUCIDOS: En este apartado se incluyen aquellas alteraciones que se producen cuando se le solicita al paciente que realice un comportamiento, acción o movimiento, es por lo que los hemos recogido bajo el término movimientos «inducidos».	
Negativismo	• Se caracteriza por la oposición o resistencia del paciente, sin motivación aparente, a seguir las instrucciones o movimientos que se le demandan. • Se puede distinguir entre: ➤ Negativismo pasivo en el que la resistencia del paciente no es activa (p. ej., se le pide que levante el brazo y no lo mueve; se le tiende la mano para saludarle, y no mueve su mano). ➤ Negativismo activo en que el paciente realiza la acción contraria a la demandada (p. ej., cuando se le pide al paciente que se levante, se sienta, o el examinador le pide al paciente que continúe andando y este se detiene).

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Obediencia automática	- En este trastorno el paciente lleva a cabo una instrucción sin importar las consecuencias. Para demostrar esto, se debe pedir al paciente que se resista a las instrucciones del examinador. - Así, por ejemplo, Emil Kraepelin les pedía a sus pacientes que sacaran la lengua, y él los pinchaba con un alfiler; los pacientes con obediencia automática seguían sacando la lengua cuando se les pedía, a pesar de que cada vez que lo hacían recibían un pinchazo que les molestaba.
Ambitendencia o ambivalencia motora	- También denominada ambivalencia motora es considerada por algunos autores como una forma leve (o previa) de negativismo. - Se refiere a la tendencia a realizar simultáneamente dos acciones que resultan antagónicas, por lo que, al iniciarse, se interfieren entre sí, y no llegan a completarse. Por ejemplo, cuando el examinador le ofrece su mano al paciente para saludarle, este mueve su mano derecha hacia la mano del examinador como si fuera a saludarle, pero antes de chocar la mano, se detiene, comienza a mover la mano de nuevo y vuelve a detenerse, y así sucesivamente, hasta que la mano finalmente se queda en reposo sin llegar a tocar, y por tanto saludar, la mano del examinador.
Perseveración motora	- Es la incapacidad para cambiar de tarea o movimiento. El paciente repite una acción, que pudo tener sentido antes, pero no actualmente. - Por lo que respecta a la perseveración motora, esta se clasifica en: ➤ Simple, cuando el paciente no cesa de realizar una actividad que se le pidió (p. ej., se le solicita que saque la lengua y la saca y mete sin cesar; se le pide que dibuje un círculo y no deja de dibujar círculos) ➤ Iterativa, cuando se repite un mismo movimiento solicitado (p. ej., dibuja un círculo, y al terminarlo, dibuja otro más) ➤ Sustitutiva, cuando se realiza de nuevo el mismo movimiento/acción previamente solicitada, a pesar de que se le pide que realice otro (p. ej., cuando después de haber dibujado el círculo que se le había pedido, se le indica que dibuje una cruz y continúa dibujando círculos). - Son signos típicos de la presencia de perseveración: ➤ El reflejo de asir (i. e., el paciente agarra cualquier objeto que se le ponga por delante sin intención de utilizarlo con algún propósito) ➤ El asimiento forzado (i. e., el paciente sigue dando la mano pese a que se le ha pedido que no lo haga) ➤ El signo del imán (i. e., el examinador toca con un dedo la palma de la mano del paciente y, al retirarlo, la mano del paciente sigue el dedo del examinador como si tuviera un imán).
Flexibilidad cérea	- Se caracteriza por una sensación de resistencia plástica cuando el examinador mueve el cuerpo del paciente, lo que se asemeja a la flexión de una varilla de cera blanda. - Cuando el movimiento pasivo se detiene, se conserva la postura final (durante un minuto o más), aunque resulte incómoda para el paciente. De manera similar, en el fenómeno de la almohada psicológica el paciente es capaz de sostener la cabeza en el aire durante horas, sin cansancio alguno.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	La flexibilidad cérica y la almohada psicológica pueden presentarse de manera independiente o asociadas a otras alteraciones, tales como la perseveración o la catatonía.
Catalepsia	- Es una alteración motora que se caracteriza por la aparición repentina y momentánea de inmovilidad y rigidez muscular, sin que la persona responda a los estímulos sensoriales. - La persona adquiere una posición inmóvil mantenida de manera constante, a veces se pueden movilizar sus miembros de manera pasiva, mostrando flexibilidad cérica, y quedándose en la posición que se dejan. Esta alteración se asocia también a la esquizofrenia con catatonía.
Ecosíntomas	- Consisten en que la persona imita los movimientos, gestos, o palabras de otra persona. - Se suele diferenciar entre: ecopraxia o (ecocinesis), en la que se da una imitación automática de los movimientos observados en otra persona; la ecomímica en la que el paciente imita los gestos de su interlocutor.
ALTERACIONES DE LOS MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS: En este apartado se clasifican aquellos movimientos que no se encuentran bajo el control voluntario de la persona, y que se engloban bajo la categoría de discinesias o espectro de las discinesias. Muchos de ellos presentan solapamiento en la semiología, y en ocasiones aparecen conjuntamente en un mismo trastorno, lo que complica su evaluación.	
Espasmos	Contracciones involuntarias de los músculos. Son muy comunes y pueden adoptar diversas formas. Se clasifican como movimientos espasmódicos la corea, balismo, mioclonía, convulsiones y tics, a diferencia del temblor, discinesia y distonía no espasmódica.
Temblor	- El término temblor remite, en general, a un movimiento no intencional, oscilatorio y rítmico que se produce por la contracción sincrónica alternante de músculos agonistas y antagonistas. - Aunque es más visible en las manos, puede observarse también en piernas, cabeza y voz. El temblor es uno de los trastornos del movimiento más frecuentes. - En general, el temblor se puede clasificar en tres tipos ➤ El temblor estático o de reposo se da cuando el miembro afectado está apoyado sobre una superficie, no activamente contraído. Este tipo de temblor suele ser fino, es decir, con poca amplitud y alta frecuencia. A menudo se observa solo en manos o dedos, aunque también en la cabeza y en la parte superior del tronco. Suele acompañarse de rigidez muscular junto con una reducción o incluso ausencia de movimientos. ➤ El temblor intencional se observa cuando la persona inicia un movimiento voluntario, como coger un objeto o tocarse la nariz con el dedo, de modo que dificulta la consecución de este. Desaparece cuando el miembro está en reposo. En ocasiones se asocia a un movimiento concreto como escribir o cantar. El temblor intencional es más grueso que el temblor estático, esto es, las oscilaciones presentan mayor amplitud y menor frecuencia. ➤ El temblor postural aparece cuando la persona trata de mantenerse en una postura en contra de la gravedad, como por ejemplo al tratar de mantener brazos o piernas extendidas. Se puede clasificar en función de la frecuencia de sus oscilaciones: el temblor de

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	acción rápida (entre 8 y 12 movimientos por segundo), que es más común en estados de ansiedad y de intoxicaciones con sustancias, y el de acción lenta (de 4 a 6 movimientos por segundo), que se asocia a enfermedades estructurales del cerebro.
Balismo	- Este es un tipo de movimiento espástico muy brusco, como un “disparo”, y de gran amplitud, que se da desde el hombro o desde la pelvis. Se produce en una extremidad, normalmente en el brazo, y solo en un lado del cuerpo (hemibalismo). - El balismo bilateral es raro y se asocia a alteraciones metabólicas. En ocasiones se presenta solo en un miembro (monobalismo). Esta alteración suele darse en pacientes que también presentan corea.
Distonía	- La distonía es un movimiento involuntario que se caracteriza por una contracción muscular sostenida en el tiempo causando retorcimiento, movimientos repetitivos, o posturas extrañas. Puede darse en todo el cuerpo, el tronco, las extremidades o el cuello. Puede estar ocasionada por una alteración genética (distonía primaria), o también secundaria a trastornos o fármacos, como los antipsicóticos - Existe una gran variedad en la velocidad en la que se dan los movimientos, desde espasmos distónicos donde se dan breves contracciones, o posturas distónicas, donde la contracción puede prolongarse durante horas o incluso días, produciendo dolor y causando una gran incapacidad. - En función de la distribución, la distonía se puede clasificar en cuatro tipos: ➤ La distonía focal se da cuando involucra a una sola área del cuerpo. Incluidas en este tipo estaría la tortícolis espasmódica, que afecta a los músculos del cuello. La distonía espasmódica, que afecta a las cuerdas vocales y puede ocasionar desde ronquera hasta afonía. ➤ Las distonías ocupacionales, profesionales, o de tareas específicas, que se pueden observar por un uso excesivo de una parte del cuerpo, como en escritores, golfistas o músicos, especialmente pianistas. ➤ La distonía segmentaria, es aquella en la que se ven involucradas dos áreas contiguas del cuerpo. Las distonías focales y las segmentarias suelen comenzar entre los 20 y los 30 años, y al inicio pueden ocurrir solo ocasionalmente o ante situaciones de estrés, hasta llegar a empeorar y mantenerse esa parte del cuerpo contorsionada. ➤ Distonía multifocal cuando se da en dos o más áreas no contiguas del cuerpo, y distonía generalizada cuando se da en el tronco y dos partes del cuerpo. La distonía que comienza en la infancia suele evolucionar a la forma generalizada, mientras que si tiene inicio en la adultez normalmente se mantiene en la forma focal o segmentaria.
Mioclónia	Se caracteriza por movimientos espasmódicos con amplitud variable muy rápidos y breves. - Puede afectar solo a una mano, o a varios músculos a la vez en el brazo, pierna, o cara. Habitualmente se distingue entre mioclónia positiva (la más frecuente), cuando se produce movimiento muscular, y negativa, cuando se produce inhibición del tono muscular. - También se clasifica en función de su etiología en:

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	➤ Esencial, cuando no se conoce la causa. ➤ Epiléptica o sintomática, cuando es secundaria a otro trastorno (p. ej., a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob). ➤ Fisiológica, donde las más frecuentes son las del sueño (hípnicas) que ocurren al conciliar el sueño o al despertar.
Convulsiones	• Las convulsiones se caracterizan por la contracción violenta, incontrolable y difusa de la musculatura voluntaria que son características de la epilepsia, pero que también se dan en traumatismos craneales, abstinencia al alcohol, tumores, trastornos metabólicos, lesiones congénitas o asociadas a la fiebre en niños, entre otros. • En función del área donde se inicia la crisis, estas se clasifican en dos grandes categorías: focales y generalizadas. ➤ Las convulsiones focales o parciales son aquellas que solo afectan a una sola área del cerebro. Aquí se incluyen las focales simples, que causan sacudidas o cambios de sensaciones, complejas, que causan confusión, y generalizadas secundarias, cuando la persona comienza con una convulsión focal y desemboca en una generalizada. ➤ Las convulsiones generalizadas, afectan a ambos lados del cerebro. Dentro de estas últimas se incluyen las convulsiones de ausencia, llamadas de epilepsia menor o pequeño mal, que pueden causar un parpadeo rápido o mirada perdida durante unos segundos; y las tonicoclónicas, también llamadas de epilepsia mayor, antes conocidas como de gran mal.
Tics	• Los tics se caracterizan por ser movimientos involuntarios repentinos, intermitentes, espasmódicos y sin objetivo. • Suelen surgir en la infancia, y la mayoría son leves y no causan interferencia a la persona. • Su aparición se agrava con la ansiedad, reduciéndose con la distracción. Un aspecto importante de los tics, y que lo diferencia de otros movimientos involuntarios como la mioclonía, corea y estereotipias, es que los tics normalmente están precedidos por una sensación de tensión previa y pueden ser suprimidos voluntariamente, aunque por un tiempo breve. • Habitualmente se clasifican en tics motores y tics vocálicos/fónicos, aunque los vocálicos son en realidad tics motores que involucran la respiración, laringe, boca y musculatura nasal, que mediante la contracción de los músculos hace que la persona emita sonidos. • Ambos tipos, en función de la forma que adopten, pueden clasificarse en tics simples, que duran milisegundos, como son el parpadeo, arrugar la nariz, o toser; y tics complejos, que duran segundos, como gestos faciales, palabras malsonantes u obscenas (coprolalia), repeticiones de sonidos, palabras o frases que se acaban de oír al interlocutor (.ecolalia) y repetición de sonidos o palabras que acaba de decir la propia persona (palilalia), aunque estos últimos algunos autores abogan por conceptualizarlos como estereotipias. También se clasifican en tics clónicos, que son repentinos y rápidos (100 ms) como el parpadeo, y los tics prolongados, de generalmente más de 300 ms. supresión ocasiona una sensación de tensión y malestar, el impulso a realizarlo, que solo es aliviado cuando se lleva a cabo.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Estereotipias	- Consisten en la repetición continuada e innecesaria de movimientos o gestos que son complejos y organizados, como el frotarse las manos o la cara, golpetear con los dedos, mecer el cuerpo, o golpearse. - Pueden aparecer cuando la persona está concentrada en alguna actividad, pero también ante emociones fuertes o aburrimiento. - A menudo la persona no se da cuenta de que está haciendo estos movimientos. - Las estereotipias, de la misma manera que los tics, se pueden clasificar en estereotipias motoras o fónicas (p. ej., gruñidos, gemidos o zumbidos), y en simples (p. ej., golpeteo de dedos, rascar, acariciar, dar palmadas en las rodillas), que suelen aparecer en las demencias, o complejas (p. ej., sentarse y levantarse de una silla), típicas de trastornos psicóticos no orgánicos. - En ocasiones algunas estereotipias pueden asemejarse a las compulsiones por su carácter estereotipado. La diferencia es que mientras que la conducta estereotipada es reforzante en sí misma y sin objetivo, los rituales se realizan para reducir la ansiedad que experimenta la persona.
Automatismos	- Son movimientos involuntarios repetitivos que se realizan sin control consciente, automático, y, por tanto, no tienen un objetivo. La persona durante el automatismo mantiene la postura y el tono muscular. Surgen en estados alterados de consciencia, en situaciones en las que la persona está confusa y no responde o su respuesta no es adecuada. - Tras el episodio la persona normalmente no recordará lo que ha hecho. - Se pueden clasificar en simples, como masticar, parpadear, succionar, o complejos, como movimiento de pedaleo, caminar o continuar con una acción que estuviera haciendo tal como conducir o limpiar. - Los automatismos son característicos de la fase previa a las crisis de la epilepsia o aura, especialmente en las crisis temporales. También pueden aparecer en traumatismos, sonambulismo, intoxicación por sustancias, y catatonía.
ALTERACIONES DE LOS MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS Y DE LA CONDUCTA INTENCIONAL: En esta categoría describiremos un conjunto de alteraciones de la conducta motora que está bajo el control voluntario y, por tanto, que son intencionales, aunque la persona puede sentir que las realiza en contra de su voluntad, es decir, que no puede resistirse a realizar la conducta.	
Comportamientos de seguridad o de búsqueda de seguridad. Se describen como comportamientos, encubiertos o manifiestos, dirigidos a prevenir o minimizar una catástrofe temida e imaginada, sentirse más protegido o a salvo.	
Evitación y escape	- Se definen como una reacción conductual o cognitiva que la persona realiza ante una situación o un estímulo que le provoca miedo o malestar con el objetivo de mantenerse lejos del estímulo o situación temida. - Se puede distinguir entre el escape o huida, es decir, cuando la persona está en la situación y sale de la misma (p. ej., el paciente con fobia a los aviones que, en la puerta de embarque, o ya sentado en el avión, decide que se marcha) ➤ La evitación activa implica que la persona realiza comportamientos dirigidos a prevenir o minimizar la posibilidad de contacto con aquello que teme de modo que elude enfrentarse al objeto temido (p. ej., el paciente no acude al aeropuerto para coger el avión; o no sube al metro)

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	➤ La evitación pasiva, en la que la persona deja de hacer algo, es decir, inhibe una conducta que ha sido previamente castigada (p. ej., el paciente no llega a comprar el billete de avión).
Compulsión o compulsiones	• Comportamientos cognitivos o conductuales repetitivos o ritualizados que se realizan en respuesta a una obsesión con el objetivo de prevenir un mal temido o disminuir la ansiedad que genera la obsesión. • A continuación, definiremos brevemente las características de las compulsiones más frecuentes en el TOC. ➤ Las compulsiones de lavado o de limpieza son conductas de limpieza estereotipadas y repetitivas que se realizan con el objetivo de eliminar los sentimientos de contaminación que amenazan la propia salud como el lavado de manos o duchas prolongadas. Se asocian a obsesiones relacionadas con la contaminación. ➤ Las compulsiones de comprobación consisten en la inspección o comprobación excesiva para, supuestamente, prevenir desgracias futuras y protegerse o proteger a los demás de posibles desastres o peligros. ➤ Las compulsiones de repetición son conductas repetitivas o estereotipadas llevadas a cabo para prevenir la ocurrencia de alguna desgracia, o de que el pensamiento se convierta en realidad, y se asocian a obsesiones de contenido altamente desagradable o evaluado como peligroso/catastrófico (p. ej., imágenes de muerte). ➤ Las compulsiones de orden y simetría responden a un intento activo por parte de las personas (habitualmente implica muchas horas) de que las cosas a su alrededor estén de acuerdo con un orden o distribución determinada o simétrica («just right»), ➤ Las conductas de acumulación consisten en la colección o almacenamiento de objetos de forma excesiva como consecuencia directa de las obsesiones (p. ej., tener que documentar y conservar todas las experiencias de vida) o compulsiones (p. ej., el paciente acumula ropa nueva sin estrenar que ha ido adquiriendo porque el proceso de lavado que tiene seguir es tan costoso -compulsiones de lavado- que no le da tiempo de realizarlo, o que evita realizarlo). ➤ Las compulsiones mentales que son las que caracterizarían a aquellas personas que se han descrito en la literatura tradicional como «obsesivos puros» (con contenidos egodistónicos como la agresión y violencia, sexuales, religiosos, inmorales y existenciales), y que realizan compulsiones mentales (con la misma función que las observables) para neutralizar sus obsesiones.
Comprobación	• Las comprobaciones hacen referencia a comprobaciones continuas (conductuales o cognitivas) de aquello temido o que constituye el centro de las preocupaciones de la persona. • Las comprobaciones se pueden dar en diferentes patologías, especialmente en los trastornos de ansiedad, trastorno dismórfico corporal, de la conducta alimentaria, o ansiedad por la enfermedad (hipocondría). • En los trastornos de la conducta alimentaria se observan comprobaciones repetidas del peso y la forma empleando el peso, espejos, o prendas de ropa para valorar posibles cambios en el peso. En la ansiedad por la enfermedad (hipocondría), las comprobaciones repetidas del cuerpo por si existen signos de una enfermedad constituyen un criterio diagnóstico (DSM-5) (i. e., comportamientos excesivos relacionados con la salud).

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	Es importante diferenciar las compulsiones de comprobación que hemos descrito con anterioridad de las conductas de comprobación, estas últimas no se realizan en respuesta a una obsesión, ni de forma tan ritualizada, ni con el objetivo de reducir el malestar que provoca la obsesión o evitar las consecuencias (temidas) que se asocian con la obsesión
Comportamientos relacionados con la apariencia, la figura y el peso corporal. En este apartado hemos recogido diferentes conductas que se realizan con objetivos diversos pero que comparten su relación con la apariencia, la figura o el peso corporal.	
Conducta de atracón	- Esta conducta hace referencia a una consumición rápida de grandes cantidades de comida con poca o ninguna satisfacción. Durante un atracón se suelen ingerir alimentos con alto contenido calórico, cuyo aporte energético puede superar entre 3 y 27 veces las calorías recomendadas al día. - El atracón suele acabar con dolor abdominal y/o sentimientos de culpa y repulsa asociados a dicha conducta Ejemplo: “Me levanté a las 5 de la mañana, fui a la cocina, tuve que quitar las dos sillas que había puesto para obstaculizar el acceso, me comí medio kilo de salchichas crudas, una barra de pan y las dos tabletas de chocolate que tenía en la despensa. No pude parar, estaba fuera de mí, después me sentí fatal, gorda, horrible, nunca voy a salir de esta situación, nada puede detenerme”
Comportamientos purgativos	Empleamos el término comportamientos purgativos en el contexto de los trastornos de la conducta alimentaria para recoger la conducta por la que la persona compensa una ingesta excesiva de caloría (p. ej., un atracón), a través de vómitos autoprovocados, empleo incorrecto de laxantes, diuréticos, o enemas. Es un especificador de la anorexia nerviosa (tipo con atracones/purgas) Ejemplo: “Después de haber comido tanto, fui al baño, me introduje los dedos y vomité, me sentí mejor”
Comportamientos restrictivos	- Los comportamientos restrictivos recogen comportamientos dirigidos a perder peso restringiendo las calorías que la persona ingiere a través de dietas o ayuno. Hermán y Mack (1975) definen la restricción como la intención que tiene la persona de restringir voluntariamente su ingesta, con el fin de mantener o conseguir el peso que considera ideal. Ejemplo: “Cuento cada caloría que ingiero, no puedo pasarme de 400, también tengo una rutina estricta de ejercicios que hago en el gimnasio durante las dos horas que tengo para comer en el trabajo, y al llegar a casa por las noches, normalmente puedo dedicar otras dos horitas. Los fines de semana si puedo hacer más ejercicio, suelo salir a correr por las mañanas”
Comportamientos agresivos. En este apartado recogeremos aquellas conductas que implican un ataque hacia la propia persona (conductas autoagresivas, autolisis) o hacia otro ser vivo (heteroagresivas).	
Comportamientos autoagresivos	- Se suele diferenciar entre las lesiones inducidas o conductas autolesivas, y los intentos de suicidio. Las primeras se describen como aquellas conductas que conllevan una destrucción directa y deliberada de una parte del propio cuerpo en ausencia de un intento de que sean letales.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	- Se excluyen aquellas conductas que son aceptadas culturalmente, por ejemplo, las que se realizan en el contexto de un ritual religioso, tatuajes, o piercing. También se excluyen formas indirectas de hacerse daño (p. ej., beber, fumar, o comer comida no saludable en exceso) que no se realizan con la intención de hacerse daño a un mismo, sino porque resultan placenteras, siendo el resultado dañino de un efecto secundario no buscado. - Las formas de autolesión más frecuentes son los cortes, quemaduras, golpes, frotarse o escoriarse la piel en exceso, o heridas fruto de pinchazos con objetos punzantes. Ejemplo: “La paciente presentaba varias quemaduras en su antebrazo que se había realizado a sí misma”
Comportamientos heteroagresivos	- Se emplea este término para referirnos a aquella conducta que tiene como resultado un daño personal o hacia la propiedad de otra persona. No suelen incluirse bajo este término el abuso verbal o los gritos, que, aunque resulten hostiles, y puedan ser precursores de una conducta violenta, no lo son en sí mismos. Ejemplo: “Cuando el paciente se cruzó con su vecino, de quien estaba convencido había pinchado su teléfono y estaba organizando un complot para arruinarle y que su mujer lo abandonara, le dio dos puñetazos”
Comportamientos relacionados con la “intención de hacer” o fase conativa. A continuación, vamos a describir dos alteraciones que no suelen categorizarse dentro del apartado de alteraciones motoras por estar asociadas a la voluntad, a la «intención de hacer», pero que ubicamos en este capítulo por su relación directa con las conductas, al estar asociadas al paso previo a la actividad: los actos impulsivos y la impulsividad, y la abulia.	
Impulsividad	- La impulsividad está dada por la presencia del deseo de realizar una impulsión inmotivada e irrefrenable que el sujeto no puede dominar. - Muchas veces el paciente siente la impulsión de robar algún objeto, sin necesidad de hacerlo pues tiene dinero para adquirirlo por la vía legal, o de agredir a alguna persona que no le ha hecho nada que justifique su agresividad.
Actos impulsivos	- Los actos impulsivos se caracterizan por ser comportamientos inapropiados en un contexto particular, expresarse de forma prematura sin deliberar ni reflexionar sobre sus consecuencias futuras, y dar lugar a consecuencias no deseadas a corto o largo plazo que la persona no había previsto. - Se trata de actos generados por la simple aparición de un estímulo exterior o de una fuerza interior o tensión, siendo tal esta fuerza que la persona suele realizar el acto. La única finalidad de los actos impulsivos es seguir el propio impulso, es decir, no hay un objetivo a la base de la realización del acto.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Abulia	- La abulia implica una disminución de la voluntad para iniciar (o completar) una conducta dirigida a objetivo. Como resultado, la persona disminuye sus actividades, y puede permanecer sentada durante largos períodos de tiempo sin interés por participar en actividades sociales o laborales. - La abulia es un síntoma negativo de la esquizofrenia, aunque se puede observar también en episodios depresivos, y en trastornos neurocognitivos
Hipobulia	Pérdida parcial de la voluntad de los pocos deseos de hacer las cosas, manifestada por un proceso de inactividad psicomotora en menor grado que la abulia. En estos casos, a pesar de ello, el paciente hace las cosas, quizás con cierta lentitud o pereza, pero las hace.
Hiperbulia	Incremento en la capacidad de decisión voluntaria del sujeto para hacer las cosas, junto con la actividad psicomotora, mientras no pierda la coordinación y si la hiperbulia tiene un sentido adaptativo no se considera anormal
Otras alteraciones del comportamiento voluntario.	
Comportamientos extravagantes	- Con el término comportamientos extravagantes nos referimos a aquellas conductas que al observador le resultan raras, extrañas, peculiares, o no adecuadas a la situación; es uno de los síntomas que la población general asocia al concepto de «locura». - Serían también conductas extravagantes aquellas relacionadas con la vestimenta y apariencia que hemos descrito con anterioridad, por ejemplo, vestir de forma inadecuada o inusual en un contexto (p. ej., en una ceremonia) o estación del año determinada. Ejemplo: “Al entrar en el cine, la paciente entregó una cuchara como si fuera la entrada al cine2
Manierismos	- Los manierismos también son conductas que resultan extravagantes, pero en este caso se emplea el término para referirse a modos característicos de hacer las cosas, variaciones propias o extrañas de conductas normales. - Al tratarse de conductas dirigidas a un objetivo que se realiza de forma inusual, o se modifica, aunque la conducta pueda tener una finalidad, el observador externo la considera inusual o extraña. Ejemplo: Entrevistador: “Caminaba de una manera extraña, el pie derecho de puntillas y el izquierdo de talón”
Bloqueo o congelación conductual, quedarse paralizado	- El bloqueo recoge la respuesta de inmovilidad ante una situación que genera miedo frente a las respuestas habituales de activación (huida o lucha). - La persona se siente paralizada, es incapaz de escapar de la situación, de moverse, puede sentir sensación de desmayo o llegar a desmayarse como ocurre en la fobia a la sangre. Ejemplo: “Cuando vi al auditorio, sentí una especie de mareo, no pude decir ni una palabra”

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Apraxia	- La apraxia es una alteración neurológica que se manifiesta por la dificultad para llevar a cabo de forma exitosa una actividad psicomotora propositiva (voluntaria) de cierta complejidad (i. e., que requiere secuenciar y coordinar movimientos) previamente aprendida y familiar, a pesar de que la persona comprende la tarea a realizar, desea realizarla, y tiene capacidad física para realizarla (i. e., tono muscular, coordinación). Ejemplo: “No sé cómo se hace, no puedo abotonarme la camisa”
Abandono de los hábitos higiénicos o del aspecto personal	Estos pacientes se dejan de bañar, de afeitarse, pelarse, se muestran sucios, desaliñados, con mal olor generalmente con los cutis seborreicos, el pelo grasiento, uñas sucias, etc.
ALTERACIONES DE LA MÍMICA Y LA EXPRESIÓN: En este apartado describiremos las alteraciones motoras que afectan a la expresión facial, gestual y a los movimientos corporales, y se diferenciará entre hipomimias, hipermimias y dismimias.	
Hipermimias	➤ Consisten en la expresión exagerada de la mímica facial o de los gestos al hablar. Existen dos tipos. ➤ Hipermimias generalizadas. Donde participan todos los músculos faciales, se observa también que la mirada no se fija en ningún punto, sino que se encuentra distraída. Existe una implicación afectiva (p. ej., la mirada hiperexpresiva, provocadora y agresiva en el contexto de un trastorno de conversión que podría estar reflejando características histriónicas). ➤ Hipermimias polarizadas: Muestran un estado afectivo monotemático. Así mismo, las muecas excesivas y las contorsiones faciales que se presentan en la catatonía son alteraciones de la expresión, pero, a menudo, se consideran también como estereotipias o resultado de la paracinesia, que se conoce como la alteración de cualquier movimiento que se ha hecho extravagante patológicamente.
Hipomimias y Animias	- Implican una disminución o ausencia de la expresión mímica, tanto en los gestos como en los movimientos. - La mirada se mantiene fija, detenida en un objeto o en el vacío. Pueden presentarse hipomimias en los episodios de depresión mayor, los trastornos neurocognitivos, la discapacidad intelectual y la esquizofrenia
Dismimias o paramimias	Reflejan una discordancia entre la expresión facial del paciente y los contenidos afectivos. A su vez se dividen en paramimias o mímicas discordantes, que suponen una contradicción entre la expresión verbal y facial del paciente (p. ej., sonrisas o risas inmotivadas, extrañas) y se observan frecuentemente en la esquizofrenia; y mímicas reflejas o ficticias que reproducen los movimientos del observador (ecomimia) en forma de espejo, y se observan en la discapacidad intelectual, la simulación, el trastorno de conversión y la esquizofrenia.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

PSICOPATOLOGÍA DE LAS FUNCIONES FISIOLÓGICAS: SUEÑO, APETITO E INGESTA Y SEXUALIDAD

Este último apartado recoge las alteraciones en los patrones de funcionamiento fisiológico. Aunque estos problemas pueden constituir, en sí mismos, el núcleo de un trastorno concreto también es muy frecuente encontrarlos en otros cuadros psicopatológicos.

PSICOPATOLOGÍA DEL SUEÑO. Se dividen en dos grandes grupos: las disomnias y las parasomnias.

DISOMNIAS. Esta categoría está relacionada con la duración, intensidad y cantidad del sueño.

Insomnio	Es la pérdida del sueño o la dificultad para dormir. El insomnio se clasifica en: – Insomnio inicial o vespertino: Es la dificultad que tiene la persona para conciliar el sueño. Al individuo le cuesta trabajo quedarse dormido, pero cuando lo hace logra dormir por lo general, si no tiene asociado algún otro tipo de trastorno del sueño. Este tipo de insomnio es característico de los cuadros de ansiedad. – Insomnio tardío o matinal: En esta modalidad, el paciente duerme la prima-noche y despierta de madrugada y no puede continuar durmiendo. Este tipo de insomnio es característico de los cuadros depresivos. – Insomnio medio o intermitente: El insomnio intermitente se presenta cuando el paciente duerme a intervalos, despierta y vuelve a conciliar el sueño, para luego despertar de nuevo y volver a dormirse, etc. – Insomnio mixto: Es la combinación de diferentes tipos de insomnio. – Insomnio total: Cuando la persona no logra dormir en toda la noche.
Hipersomnia	• Las pacientes hipersomnias duermen demasiado, siempre se muestran somnolientos • En este caso debemos tener en cuenta que normalmente hay personas que necesitan más de 8 horas de sueño en 24 horas.
Narcolepsia	• La narcolepsia es un síndrome de origen desconocido caracterizado por ataques anormales de sueño. Por lo que se van a considerar los siguientes síntomas: 1. Somnolencia diurna excesiva: los pacientes presentan ataques de sueño agudos durante circunstancias que se podrían considerar estimulantes. Este episodio dura entre 10 y 15 minutos y suele haber un periodo refractario de varias horas antes del próximo episodio. 2. Cataplexia: es una alteración de la psicomotricidad por entrar de repente en la fase REM. Lo que el sujeto experimentará es una repentina disminución del tono muscular (generalizada o localizada) estando totalmente consciente de ello. Usualmente se va a desencadenar por emociones intensas como la risa, el llanto o la ira y durará pocos segundos. Estos episodios se iniciarán años después de establecerse la somnolencia diurna.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

	3. Parálisis del sueño: es un estado que mantiene similitud con la cataplexia puesto que, el paciente siente que no puede moverse, hablar o respirar con naturalidad. La diferencia está en que éste no va a tener desencadenantes emocionales. Su duración no excederá los pocos minutos, pudiendo cesar antes frente a estímulos externos. 4. Alucinaciones hipnagógicas: los episodios alucinógenos son pseudopercepciones de índole auditiva o visual. No aparecerán hasta la adolescencia y van a tender a disminuir con el tiempo. Hay casos en los que la parálisis y las alucinaciones se dan simultáneamente convirtiéndose en un evento terrorífico para el paciente.
Relacionados con la respiración: El síndrome de apnea del sueño es una alteración de la respiración que se caracteriza por la interrupción repetitiva (más de 10 segundos) del flujo aéreo naso bucal durante el sueño.	
Apnea del sueño obstructiva	• Consiste en el cese del flujo aéreo, volviéndose a iniciar de manera repentina. • Esta es la apnea más común. Durante el sueño, los músculos se relajan y las vías respiratorias se estrechan por lo que, la respiración se vuelve inadecuada por 10 a 20 segundos. • El encéfalo detecta la anomalía y despierta al sujeto. El signo más característico será el ronquido, dado que las paredes de la garganta colapsan.
Apnea del sueño central	• Consiste en el cese parcial del ritmo respiratorio debido a que las neuronas eferentes del encéfalo evitan que los músculos que controlan la respiración actúen de forma correcta. • Esto va a ocurrir únicamente en casos en los que el SNC se haya lesionado.
Apnea del sueño mixta	• Va a ser la combinación de las dos apneas anteriormente mencionadas. • Unas veces se va a paralizar el sistema respiratorio y en otras habrá una obstrucción.
Relacionados al ritmo circadiano: Son alteraciones del sueño debidas a una desorganización del sueño-vigilia ; es decir, se duermen las horas correspondientes, pero los horarios de sueño están alterados. Los seres humanos se rigen por los ritmos circadianos, que están vinculados con la temperatura, la genética y la exposición a la luz. Además, el cuerpo tiene una hormona llamada melatonina que se libera durante la noche y es la que induce al sueño. Todos estos elementos van a provocar los patrones por los que la persona despierta y se duerme. Dentro de este grupo encontramos a los siguientes trastornos:	
Tipo de fases de sueño retardadas	• Surge por una demora al momento de ir a dormir (más de 2 h)
Tipo de fases de sueño avanzadas	• Sus biomarcadores circadianos se han programados 2 a 4h antes de lo habitual puesto que, se han acostumbrado a madrugar.
Tipo asociado a turnos laborales	• Le ocurre a las personas que tienen horarios de trabajo poco comunes, por ejemplo, una semana trabaja durante la noche y otra semana trabaja durante la mañana. Esto interfieren en el mantenimiento de un horario de sueño-vigilia normal.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

PARASOMNIAS: Son anomalías se producen en fase REM y NO REM del sueño.

Pesadillas	- Las pesadillas son episodios que ocurren durante el sueño REM y tiene que ver con el contenido de lo que se está soñando, que puede ser terrorífico, angustiante o amenazante. - La ansiedad puede provocar una reacción motora que despierte al individuo. Sin embargo, la ansiedad se irá disipando en la medida que reconozca que sólo estaba soñando. - Se pueden experimentar pesadillas independientemente de la edad, aunque son más comunes en niños. No se conoce con exactitud su etiología, pero existen teorías que consideran tiene un significado importante para la persona.
Terrores nocturnos	- Los terrores nocturnos suelen producirse en las fases III o IV del sueño. Inician con un grito angustiante y desgarrador en mitad de la noche. - Generalmente, la persona se levantará con una sensación angustiante difusa, sin saber exactamente qué ha ocurrido ni recordar nada. Su etiología se cree guarda relación con la tensión emocional y la fatiga.
Sonambulismo	- El sonambulismo se caracteriza por una secuencia movimientos corporales que el sujeto realiza durante el sueño de ondas lentas. La persona puede llegar a levantarse y realizar diversas actividades como caminar por la casa o mover cosas. - También podría articular algunas palabras. Durante este estado, la persona no reacciona a los estímulos ambientales. - Su duración puede ser de 1 a 30 minutos y puede ocurrir varias veces por semana a lo largo de la vida. - Este trastorno se va a desencadenar aún más en épocas de estrés.

PSICOPATOLOGÍA DEL APETITO E INGESTA: Los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con la cantidad de comida ingerida, y con la función de la comida dentro de la vida del paciente

Anorexia	- La anorexia es la pérdida total o parcial del apetito o los deseos de ingerir alimentos. - Se caracteriza por la restricción de la comida, sobre todo si posee un alto nivel calórico. - Se limita a ciertos alimentos, en algunos casos practica ejercicio físico en exceso, dado que su único objetivo es adelgazar. La pérdida de peso puede ser gradual, de manera que el cuerpo se va adaptando al nuevo estado de malnutrición.
Bulimia	- La bulimia es el síntoma opuesto de la anorexia, se caracteriza por episodios recurrentes de excesiva ingesta de alimentos seguidos de conductas compensatorias. - En estos casos, el paciente se siente hambriento en todo momento. No llega a saciar su hambre, aunque haya comido lo suficiente.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

OTRAS ALTERACIONES ALIMENTARIAS.

Rumiación alimentaria	Regurgitar la comida, re-masticarla y luego la deglutirla. Aparece en el 10% de los retrasos mentales y con frecuencia en demencias.
Pica	- La pica es el hábito de comer sustancias inorgánicas no apropiadas para la ingestión, tales como la cal o la tierra, arena, plastilina, excrementos de animales, hojas, etc. - Aparece en niños retrasos o demencias y puede llevar a la muerte. No hablamos de pica si se ingiere algo no nutriente admitido por la cultura (en África las embarazadas comen tiza por su alto contenido en calcio).
Malacia	- La malacia es el hábito de combinar sabores que comúnmente no combinan en la alimentación. Ejemplo: comer mango ligado con arroz, frijoles con postres, etc.
Coprofagia	Es el deseo de ingestión de heces fecales u otras sustancias de origen orgánico pero que no están de forma apropiada para la alimentación.

PSICOPATOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD: Se refiere a la conducta sexual, se trata de un indicador biológico sensible del bienestar general del individuo que no es raro que aparezca cuando la persona comienza a tener problemas. Al igual que en las funciones anteriores, nos podemos encontrar tanto con déficit en la libido como con incrementos en el apetito sexual y en su actividad.

Disforia de género	- Anteriormente denominado trastorno de la identidad sexual se define como la disconformidad de un individuo con su sexo biológico, debido a que existe una identificación persistente o dan por hecho que pertenecen al sexo opuesto. - Esta psicopatología está acompañada de una profunda insatisfacción con el sexo asignado, así como repudio o malestar hacia las características, tanto primarias como secundarias, propias de cada sexo.
Disfunciones sexuales	- Es la alteración en alguna de las fases de la respuesta sexual, cuyas fases son: ➤ Deseo: Aparecen fantasías sexuales, cambios hormonales y deseo de actividad sexual ➤ Excitación. Aumenta la tensión muscular, respiratoria y cardíaca. En varones, la vasoconstricción provoca la erección del pene. En la mujer, la dilatación de la vagina y su lubricación. ➤ Meseta: Consiste en el mantenimiento de fase de excitación, con una preparación para el orgasmo. ➤ Orgasmo. Existen contracciones involuntarias musculares, la respiración y el ritmo cardíaco alcanzan su máximo. Hay una fuerte sensación de placer. ➤ Resolución. Se libera la tensión muscular y el organismo se relaja.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Alteraciones del deseo sexual:	
Anafrodisia	Se caracteriza por la pérdida del deseo sexual.
Hiposexualidad o hipoerotismo	- Se caracteriza por la marcada disminución del apetito sexual con escasas de fantasías. - Su principal etiología como psicopatología son los problemas de carácter emocional, mientras que biológicamente es causado por problemas neurológicos. - Se puede dar en comorbilidad con la epilepsia y la depresión, por daños en el sistema límbico, desbalance endocrino e inducida por medicación.
Aversión al sexo	- Es la sensación de asco, temor o ansiedad ante la sola posibilidad de tener relaciones sexuales. - Este trastorno está causado principalmente por experiencias sexuales negativas, como violaciones. - Puede ser generalizado, cuando la aversión es provocada hacia todo tipo de actividad sexual (ya sean besos o abrazos apasionados). - También puede ser específico o focalizado cuando la aversión se genera por determinado factor o elemento de la actividad sexual, como la penetración vaginal o las secreciones genitales (flujos vaginales o semen).
Hipersexualidad o hipererotismo	- Es el aumento de la libido y de la actividad sexual, siendo esta última una característica muy relevante. - La hipersexualidad genera que las personas se estimulen sexualmente de forma reiterada, ante estímulos visuales o pensamientos. Generalmente se presenta en personas que han sido reprimidos sexualmente durante las primeras etapas del desarrollo (infancia y adolescencia). - Esta patología se presenta con mucha frecuencia en personas con un trastorno de la personalidad u otras alteraciones mentales, tales como la satiriasis (exclusiva en hombre) o la ninfomanía (exclusiva en mujeres), conocidas popularmente como “adicción al sexo”, que se caracterizan por un aumento de la libido y del deseo sexual, lo que genera que las actividades sexuales aumenten.
Alteraciones de la excitación sexual:	
Trastorno eréctil en el hombre	- También denominado disfunción eréctil, se define como la inhabilitación para obtener o mantener una erección, ya sea de forma persistente, o recurrente (cuando no ocurre siempre). - Esta patología impide iniciar o mantener relaciones sexuales puesto que no se puede consumir la penetración, lo que a su vez genera un deterioro en las relaciones interpersonal en la pareja.
Trastorno de la excitación sexual en mujeres	- Esta patología se define como la incapacidad de mantener la respuesta de la lubricación vaginal que es propia de la etapa de excitación y al igual que en el caso del trastorno eréctil en el hombre, esta puede ser recurrente o persistente. - Y así mismo puede provocar malestar y deterioro en las relaciones interpersonal en la pareja.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Alteraciones orgásmicas:	
Eyacuación prematura	- Es la pérdida de control sobre los reflejos eyaculatorios, que generan una eyacuación casi inmediata como respuesta a un estímulo sexual leve (o bien antes, durante, incluso poco tiempo después de realizar el coito). - Este trastorno genera malestar y problemas en las relaciones interpersonales a quien lo padece. - Puede ser adquirido o de nacimiento, y generalizado o situacional. Además, se pueden diferenciar tres niveles: ➤ Leve que se da cuando el estímulo sexual provoca la respuesta eyaculatoria en un laxo de 30 a 60 segundos. ➤ Moderado, cuando la respuesta eyaculatoria tiene lugar entre 15 y 30 segundos después de la presencia del estímulo. ➤ Grave, cuando la eyacuación se da en menos de 15. - El criterio diagnóstico que determina el trastorno de eyacuación precoz se da cuando la eyacuación tiene lugar antes de que la persona lo desee, y que este problema se presente durante, como mínimo, seis meses.
Eyacuación retardada	Ausencia de eyacuación (aneyacuación) o la presencia de ésta de forma retardada (30-45 minutos) posterior a la penetración o ante cualquier actividad sexual. - Este trastorno es generalmente de carácter psicológico, aunque también puede darse como consecuencia de alteraciones orgánicas provocadas por el consumo de fármacos, especialmente los antidepresivos, y por daños neurológicos como trauma en los nervios pélvicos o espina dorsal.
Alteraciones sexuales por dolor:	
Dispareunia	5% en varones 15% en mujeres. La persona tiene dolor (en la zona genital o en otro sitio) en el momento de la respuesta sexual. - Se descarta en el caso de que este provocado por enfermedad médica.
Vaginismo	- No confundir con vaginitis. Espasmos involuntarios en el tercio externo de la vagina. Si se intenta la penetración hay dolor.
Parafilias: Antiguamente denominadas desviaciones sexuales . Están relacionados con una actividad sexual en la que el objeto, la persona o las prácticas no son adecuadas . Hay muchísimas y no existe alteración en la respuesta sexual, tienen todas las fases.	
Tipos: – Pedofilia (niños) – Incesto (familiares) – Zoofilia (animales) – Coprofilia (heces) – Urofilia (orina) – Klismafilia (enemas)	

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

– Fetichismo (objetos inanimados)	
Fetichismo	- Cualquier objeto puede ser fetiche, aunque destaca la ropa interior y los zapatos. También puede ser que sea una parte del cuerpo (parcialismos) - Hay tres tipos: - La excitación es producida por estimulación táctil. - Aquellos en los que es el objeto el que produce la excitación. - Fetichismo travestista: la persona se excita con la ropa del otro sexo.
Voyerismo y exhibicionismo	No es raro que aparezcan en la misma persona. Le excita que le pillen mirando a escondidas a otras personas manteniendo relaciones, o el mostrar el propio cuerpo a quien no se lo espera.
Sadismo y masoquismo sexual	- El sádico le hace daño al otro y le humilla. - El masoquista recibir daño y humillación de otro, ambas tendencias provocan mucho placer a quien lo padece.
Pedofilia e incesto	Incesto: se mantienen relaciones entre familiares (padre – hija; tío – sobrina). Hay quien no considera incesto a las relaciones entre hermanos; no es la opinión del autor. Las víctimas suelen ser niñas que ya han entrado en una época de desarrollo sexual. Pedofilia: Se excitan con los niños en general.

PSICOPATOLOGÍA DE LAS FUNCIONES DE RELACIÓN

Relaciones consigo mismo	- Aquí se valora la autoapreciación de cualidades positivas y negativas. ¿Qué piensa usted de sí mismo? ¿Como lo valoran otras personas generalmente? ¿Le gusta ser como es o prefiere ser como otra persona? ¿Con qué características? ¿Cómo le gustaría ser? ¿Qué piensan los demás de él?
Relaciones con las demás personas	- Se enfoca directamente al tipo de relaciones intrapersonales que el sujeto suele establecer. ¿Cómo eres tú en tus relaciones con las demás personas? ¿Qué piensas tú de las demás personas?
Relaciones con las cosas	- Es importante saber cuáles son los intereses que tiene el paciente en la vida. Hay personas que tienen intereses científicos, otras artísticos, literarios, políticos, etc., ¿Qué es lo que más le interesa en la vida? ¿Qué es lo que menos le interesa? ¿Cuáles son sus ideales más importantes? ¿A qué dedica su tiempo libre? ¿Qué es lo que más le motiva hacer? ¿Lo que más disfruta y lo que menos?



PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA
SEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

Referencias Bibliográficas:

- Belloch Fuster, A. (2020). Manual de psicopatología.
- Caballo, V., Carroble, A., & Salazar, I. (2014). *Manual de Psicopatología*. Madrid: Pirámide.
- Peña-Herrera, B. (2018). Psicopatología General. Universidad Espíritu Santo- Ecuador.
- Oyebode, F. (2024). *Sims. Síntomas mentales: Manual de psicopatología descriptiva*. Elsevier Health Sciences.